



OUVIDORIA DO SUS

uma inovação social, caminho
para a integridade

Cristina Ayoub Riche

Rosa Maria Pinheiro Souza

Organizadora

REDESCOLA



Este livro traz contribuições inequívocas à compreensão do papel e à atuação das Ouvidorias, no sistema público brasileiro de saúde – o SUS, contemplando temas e questões relevantes presentes na agenda e no cotidiano das ouvidoras e dos ouvidores estaduais e municipais.

Ao abordar a atuação das ouvidorias de saúde à luz das contribuições teóricas e práticas, esta publicação reforça a importância da participação social como um dos alicerces do SUS. Com esse olhar, aprofunda os temas da integridade institucional e da gestão de riscos institucionais, tão caros para o aprimoramento da gestão e para o aperfeiçoamento dos sistemas públicos de saúde.

Disseminar conhecimentos ao expor essas temáticas, por vezes ainda pouco exploradas ou não suficientemente conhecidas, constitui um avanço significativo para o entendimento da potência das ouvidorias e da relevância da qualificação de sua atuação.

Boas políticas e boas práticas contribuem para o exercício da missão da Ouvidoria, de acordo com os princípios éticos, a transparência, a inovação social e o respeito aos direitos de cidadania. É nessa perspectiva que os aportes aqui contemplados ganham destaque e relevância para o fortalecimento do SUS.

Rosa Maria Pinheiro Souza

*Coordenadora Nacional do Projeto
Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS*



OUVIDORIA DO SUS

uma inovação social, caminho
para a integridade

Cristina Ayoub Riche

Rosa Maria Pinheiro Souza

Organizadora

REDESCOLA



Ministério da Saúde – MS

Ouvidoria-Geral do SUS

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz

Presidente

Mario Moreira

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP

Diretor

Marco Antonio Carneiro Menezes

Vice-Direção da Escola de Governo em Saúde – VDEGS/ENSP

Vice-Diretor

Eduardo Alves Melo

Secretaria Técnica-Executiva da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública – RedEscola

Coordenadora

Márcia Cristina Rodrigues Fausto

Projeto Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde

Coordenadora Nacional

Rosa Maria Pinheiro Souza

Ouvidoria do SUS: uma inovação social, caminho para a integridade

Organizadora

Rosa Maria Pinheiro Souza

Analista sênior de gestão em saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz). Coordenou a Secretaria Técnica-Executiva da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública (RedEscola) de 21/5/2014 a 12/7/2023. Atualmente é coordenadora nacional do Projeto Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde e de outros projetos estratégicos voltados para ouvidorias, auditorias e participação social no SUS.

Autora

Cristina Ayoub Riche

Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), advogada, mediadora de conflitos, doutora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da mesma universidade. Foi presidenta do Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) de 2019 a 2023. Coordenadora do Grupo de Trabalho Unificação das Cartas dos Serviços das Unidades Hospitalares da UFRJ e membro do júri do Prêmio Cecília Donnangelo de Ouvidoria SUS (2013), entre outras ações na área de saúde pública.

Documento elaborado de acordo com a Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da Fiocruz. Os textos desta obra podem ser copiados e compartilhados desde que: não sejam utilizados para fins comerciais; seja citada a fonte e atribuídos os devidos créditos.

Produção editorial realizada pela Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação a Distância da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (CDEAD/ENSP/Fiocruz).

Supervisão editorial

Maria Leonor de M. S. Leal

Revisão editorial/tipográfica

Christiane Abbade

Pesquisa bibliográfica e sistematização dos resultados

Nuno dos Santos Francisco Junior

Capa, projeto gráfico, diagramação e tratamento de imagem

Felipe Teixeira – Agência Guindaste

Revisão de texto e de referências

Maria Auxiliadora Nogueira

Simone Teles

Sonia Kritz

Pesquisa e projeto gráfico

Jean Souza – Agência Guindaste

Catálogo na fonte

Fundação Oswaldo Cruz

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde

Biblioteca de Saúde Pública

R527o

Riche, Cristina Ayoub

Ouvidoria do SUS: uma inovação social, caminho para a integridade / Cristina Ayoub Riche. – Rio de Janeiro, RJ: Fiocruz, ENSP, Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação a Distância, 2024.

9.732 kb : il. color. ; tab ; PDF

ISBN: 978-65-89501-72-5

Inclui Bibliografia

1. Sistema Único de Saúde. 2. Acesso à Informação. 3. Democracia. 4. Ouvidoria. 5. Inovação Social. 6. Integridade Institucional. I. Souza, Rosa Maria Pinheiro (Org.). II. Título.

CDD - 23.ed. – 338.47014

Como referenciar esta obra segundo a ABNT

RICHE, Cristina Ayoub. *Ouvidoria do SUS: uma inovação social, caminho para a integridade*. Rosa Maria Pinheiro Souza (org.). Rio de Janeiro: RedEscola: Fiocruz/ENSP: Ministério da Saúde/SUS, 2024.

2024

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz

Rua Leopoldo Bulhões, n. 1480 • Manguinhos, Rio de Janeiro. CEP: 21041-210

Tel.: (21) 2598-2525

www.ensp.fiocruz.br

Agradecimentos

Nossos mais sinceros agradecimentos à colaboração preciosa de:

Cynthia Miranda Pinto

Coordenadora de Gestão da Informação em Ouvidorias do SUS

Cristiane Helena Couto Araújo

Coordenadora do Atendimento ao Cidadão e das Ouvidorias do SUS

Guilherme Grili

Coordenador de Gestão da Informação em Ouvidorias do SUS

Musa Denaise de Sousa Moraes

Coordenadora do Atendimento ao Cidadão e das Ouvidorias do SUS

Renata Carvalho Lustosa

Assessora do Gabinete da Ouvidoria-Geral do SUS

Ouvidoria do SUS

Pesquisa na ouvidoria
SUS em desenvolvimento
Gerando conhecimento
Promove a cidadania
Saúde com democracia
Equipe em integração
E com capacitação
Qualifica a governança
E os processos de mudanças
Pro sistema em promoção

Parceria com a Fiocruz
Gestão institucional
Participação social
População é quem conduz
E na Ouvidoria do SUS
Comunicação assertiva
Redes colaborativas
Melhorando a qualidade
Caminho pra integridade
Em gestão participativa

Domicio Sá

Pesquisador da Fiocruz/Pernambuco



Sumário

Prefácio.....	11
Apresentação.....	13
1. Introdução.....	19
Problema de pesquisa.....	20
Objetivos.....	21
Metodologia.....	22
2. Ouvidorias, democracia participativa e as ouvidorias do SUS.....	23
3. Como contribuir para que as pessoas tenham acesso à informação?.....	34
4. Como a ouvidoria se insere no contexto da integridade pública e da área de saúde pública?.....	41
5. Arcabouço da normativa brasileira com aplicação nas ouvidorias; principais diretrizes das normativas em ouvidoria.....	50
6. Boas práticas de ouvidorias implementadas no âmbito do SUS.....	65
Ouvidoria itinerante como instrumento de gestão.....	67
Busca ativa para incentivar a democracia participativa.....	68
A ouvidoria no processo de aquisição de medicamentos.....	69
7. Atuação das ouvidorias do SUS no Brasil.....	70
8. Recomendações.....	85
9. Implicações práticas e teóricas.....	98
10. Considerações finais.....	100
11. Referências.....	102
Anexo A – Relatório do levantamento bibliográfico para o Projeto Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS.....	109

O livro intitulado *Ouvidoria do SUS: uma inovação social, caminho para a integridade* dialoga com minha trajetória profissional como gestor e pesquisador da Fiocruz, marcada pela defesa da democracia participativa, do processo de formação dos profissionais de saúde e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A obra trata de um projeto nacional que contribuiu significativamente para reduzir as desigualdades nos processos educativos voltados ao fortalecimento das ouvidorias estaduais e municipais da saúde, qualificando os ouvidores e as ouvidoras do SUS.

As ouvidorias do SUS têm como objetivo central garantir e ampliar o acesso dos cidadãos e das cidadãs aos seus direitos, bem como manter os mecanismos de gestão e controle social na saúde. São espaços de participação social nos quais a escuta qualificada e o tratamento eficiente das manifestações traduzem o exercício de cidadania, aproximando a sociedade do Estado, para melhorar os serviços públicos e subsidiar políticas públicas.

A publicação, de autoria de Cristina Ayoub Riche e organizada por Rosa Souza, que também coordenou o projeto Fortalecimento das Ouvidorias do SUS, aborda questões relevantes ainda não exploradas o suficiente, como o papel das ouvidorias na integridade institucional e na gestão de riscos institucionais aplicada ao SUS.

O conteúdo avança para outras questões relevantes na agenda dos gestores e gestoras e dos ouvidores e ouvidoras do SUS, compartilhando conhecimentos e experiências que dialogam com o cotidiano dessas estruturas institucionais, no intuito de apoiar e valorizar a atuação desses profissionais na linha de frente do atendimento às necessidades da população.

Ao ler o livro, somos convidados a reconhecer a importância das ouvidorias no contexto do SUS, entendendo a natureza complexa de seu trabalho para as transformações necessárias, alinhadas aos princípios democráticos em um Brasil diverso e desigual.

Que nosso compromisso por uma sociedade igualitária, justa e baseada no respeito às culturas, no respeito à diversidade, na dignidade humana e na liberdade seja a motivação para garantir os direitos de cidadania para todos os brasileiros e brasileiras.

Boa leitura!

Hermano Albuquerque de Castro
Vice-Presidente de Ambiente, Atenção
e Promoção da Saúde (VPPAPS/Fiocruz)
Ex-Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz)



Apresentação

A publicação *Ouvidoria do SUS: uma inovação social, caminho para a integridade* representa a culminância do Projeto Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS, que consiste em uma iniciativa para promover a capacitação de gestores, profissionais e trabalhadores de ouvidoria, no intuito de aprimorar o atendimento às cidadãs e aos cidadãos e de buscar a melhoria contínua do sistema de saúde. Esse projeto desdobrou-se em metas e atividades estratégicas, desenvolvidas por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED 193/2019).

O projeto foi levado a efeito a partir de uma parceria entre a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) e a Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (OuvSUS) do Ministério da Saúde (MS), coordenado pela Secretaria Técnica e Executiva da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública (RedEscola) e envolvendo ouvidoras e ouvidores municipais e estaduais do setor público de saúde, com abrangência nacional.

A RedEscola é um espaço de diálogo permanente, favorável à construção de consensos em torno de uma educação permanente que valoriza a transformação das práticas profissionais e traz no seu cerne o fortalecimento do controle social. As ouvidorias do SUS são instrumentos de democracia participativa e constituem-se em instâncias de participação social que aproximam o Estado da sociedade, configurando um espaço democrático essencial ao aprimoramento dos serviços públicos de saúde e à garantia dos direitos de cidadania.

A trajetória desse projeto foi marcada por grandes desafios. A chegada da pandemia de covid-19 impôs a necessidade de uma adaptação ágil e significativa das atividades inicialmente previstas, as quais foram reconfiguradas, permitindo que todos os compromissos fossem cumpridos, mesmo diante das circunstâncias adversas, impostas pelo período pandêmico.

O projeto contou com a participação da Coordenação de Desenvolvimento Educacional e EAD (CDEAD/ENSP/Fiocruz) e foi delineado em quatro metas estruturantes, conforme sintetizado no esquema a seguir.

META 1	Ofertar duas mil vagas para programa de capacitação na modalidade de ensino a distância (EAD), para qualificação dos profissionais das ouvidorias do SUS em todo o território nacional.
META 2	Ofertar programa de capacitação na modalidade presencial para mais de 900 instituições em todo o território nacional.
META 3	Avaliar e monitorar o desenvolvimento das atividades pedagógicas nas modalidades presenciais e EAD.
META 4	Realizar pesquisa e estudo na área de ouvidoria e participação social, aplicada aos processos de integridade institucional; na área correccional, envolvendo atividades disciplinar e responsabilização administrativa de entes privados; na área de gestão de riscos institucionais, aplicada ao campo da saúde pública.

Esta publicação se associa aos processos formativos, que foram desenvolvidos no âmbito do projeto Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS, cujos resultados são sumarizados a seguir:

Oficinas Remotas	Comunidade de Práticas
31 oficinas remotas realizadas 910 ouvidorias capacitadas 1027 concluintes 597 municípios alcançados 29 facilitadores de aprendizagem 21 apoiadores pedagógicos	3.800 vagas ofertadas 1.740 participantes 16 facilitadores de aprendizagem

Em função da pandemia de covid-19, todas as metas precisaram ser readaptadas, sendo que a 2 e a 4 sofreram alterações mais significativas.

A meta 1, como já se tratava da modalidade EAD, manteve as estratégias pedagógicas originais, mas todo o processo de elaboração, que se dava por meio de oficinas presenciais, precisou ser reestruturado para formato remoto, contando com novas tecnologias que foram sendo apropriadas e que exigiram o estabelecimento de uma nova temporalidade.

Na meta 2, as oficinas programadas para acontecerem no formato presencial precisaram sofrer uma adaptação para a modalidade remota, o que, neste caso, exigiu a adaptação das estratégias pedagógicas a serem desenvolvidas, bem como dos recursos e materiais que seriam utilizados ao longo das atividades.

Fotos 1, 2 e 3 – Reunião da OuvSUS em julho de 2023



Fonte: Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (2023).

A meta 3, que correspondeu à avaliação das atividades educacionais (metas 1 e 2), precisou ser adaptada, especialmente no que se referia à meta 2, passando a ser realizada totalmente a distância por meio do sistema de avaliação online (SAOL). A avaliação trouxe dados qualitativos bastante relevantes, possibilitando o aprimoramento ao longo das atividades educativas.

A meta 4, que tem como fruto a presente publicação, apresentava como formulação inicial o seguinte enunciado: realizar pesquisa e estudo na área de ouvidoria e participação social, aplicada aos processos de integridade institucional; na área

correcional, envolvendo atividade disciplinar e responsabilização administrativa de entes privados; na área de gestão de riscos institucionais aplicada ao campo da saúde pública. A fim de compatibilizar essa meta com os propósitos e a realidade das ouvidorias do SUS, essa elaboração foi reconfigurada mediante autorização da Coordenação da Ouvidoria-Geral do SUS, passando a ter uma nova redação: “realizar pesquisa e estudo na área de ouvidoria e participação social, aplicada aos processos de integridade institucional; na área correcional e na área de gestão de riscos institucionais, aplicada ao SUS”.

Nessa perspectiva, a publicação dos resultados da pesquisa no formato proposto contribui sobremaneira para reduzir a lacuna de referenciais bibliográficos de suporte às ouvidorias, especialmente na temática apresentada, situação evidenciada na etapa de levantamento e sistematização da literatura sobre os temas em foco.

O objetivo da pesquisa foi inspirado na compreensão da necessidade de produzir e disseminar conhecimento sobre as áreas contempladas, e esta publicação disponibiliza às ouvidoras e aos ouvidores da saúde, com acesso livre e gratuito, um arcabouço de conhecimentos relevantes para orientar a atuação das ouvidorias, pautada na ética, na integridade e no respeito à população, em direção à efetiva participação social.

Tal iniciativa mobilizou um conjunto de movimentos e envolveu distintos atores sociais e estratégicos, oriundos de distintas instituições governamentais, em oficinas e reuniões de trabalho. Dentre aqueles movimentos empreendidos, destaca-se a participação primorosa da autora, Dra. Cristina Ayoub Riche, Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),

Presidenta do Instituto Latinoamericano del Ombudsman/Defensorías del Pueblo (ILO) de 2019 a 2023 e ex-Ouvidora-Geral da UFRJ, reconhecida nacional e internacionalmente e com larga experiência na temática abordada.

É mister destacar que os esforços envidados para a consecução dos resultados alcançados contaram com a parceria valiosa da equipe da OuvSUS durante a execução desse projeto, dentro da lógica de um trabalho colaborativo em prol do fortalecimento do Sistema Nacional de Ouvidoria do SUS e do respeito aos direitos de cidadania.

Por fim, expresso aqui os nossos agradecimentos a todos os que se envolveram nessa iniciativa que traduz o nosso compromisso de fortalecer e consolidar o SUS. A nossa expectativa é que as ouvidoras e os ouvidores do SUS, ao terem contato com esta leitura, sintam fortemente o desejo de mudança e concretizem os esforços de seguirem na luta pela garantia dos direitos de cidadania para todas as brasileiras e todos os brasileiros!

Rosa Maria Pinheiro Souza
Coordenadora Nacional do Projeto
Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS



1. Introdução

*É preciso agir como se fosse possível
transformar radicalmente o mundo.*

E você tem que fazer isso o tempo todo.

Angela Davis (*apud* Jean-Philippe, 2020,
tradução nossa).

Com base no cenário nacional e em levantamento bibliográfico realizado, esta publicação busca avaliar a atuação das ouvidorias, no âmbito do SUS, com a finalidade de analisar as contribuições teóricas e práticas para o fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS, no tocante à integridade institucional.

O estudo aprofunda dois pontos considerados de suma importância no contexto de promoção da integridade institucional:

1. o papel das ouvidorias nos processos de integridade institucional na área correcional;
2. a atuação desses institutos na área de gestão de riscos institucionais aplicada ao SUS.

Investiga, ainda, a contribuição das ouvidorias para o fortalecimento do SUS e dos processos de gestão e governança estaduais e municipais, analisando seu impacto na transparência pública, na melhoria de processos de atendimento ao público, na conduta ética, na inovação social e no fortalecimento da democracia participativa, entre outras questões.

O estudo pretende identificar oportunidades para fortalecimento do sistema de ouvidorias nos âmbitos estadual e municipal, bem como mapear lacunas no tocante à sua estruturação e integração com os gestores do Executivo.

Problema de pesquisa

As ouvidorias no SUS exercem papel fundamental para fornecer aos cidadãos e às cidadãs a possibilidade de contribuírem ativamente na construção de um sistema de saúde público mais amplo e politicamente engajado com o acesso à saúde para todas as pessoas.

No levantamento apresentado neste trabalho (Anexo A – Relatório do levantamento bibliográfico para o Projeto Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS), observa-se que a maioria das pesquisas feitas sobre ouvidoria da saúde tem como foco principal a ampliação da participação social no SUS e a luta pela garantia dos direitos da população. Entretanto, em livros, dissertações e teses ainda há poucas informações mais específicas sobre o tema, sobretudo sob a ótica de *compliance* e combate à corrupção.

1. Acesso à Informação: como as ouvidorias podem contribuir de maneira efetiva para o processo de reconhecimento dos direitos de acesso à informação por parte dos cidadãos e das cidadãs?

2. Inserção da ouvidoria no contexto da integridade pública e da saúde pública: de que forma a ouvidoria se insere nos contextos mais amplos da integridade pública e da saúde pública?

3. Qual é o estado atual do arcabouço normativo brasileiro aplicável às ouvidorias, e como essas normativas influenciam o trabalho dessas entidades?

Objetivos

Com objetivo de promover a valorização e a qualificação das ouvidorias, este documento apresenta propostas para gestão e governança, para processos formativos de ouvidores e ouvidoras, bem como sugestões de canais, organizações de referência para orientações sobre o tema integridade, referenciais teóricos para a ouvidoria da área de saúde pública e legislações de apoio ao trabalho diário das pessoas que atuam em ouvidoria.

Trata-se de um material de consulta para gestores públicos em interface com ouvidores e ouvidoras, profissionais da área de saúde pública, formuladores e formuladoras de políticas públicas e outras pessoas interessadas no tema.

A publicação também se propõe a explorar o arcabouço teórico e as diferentes normativas para a promoção dos direitos humanos, em âmbito global, que podem servir como base para o trabalho em ouvidoria, compreendendo os profissionais da área como agentes de intervenção social, da promoção e da garantia de diferentes direitos fundamentais e da democracia participativa.

Metodologia

A metodologia utilizada foi, primeiramente, o levantamento e a revisão bibliográfica relativos aos diferentes tópicos abordados, por meio de método exploratório. Em seguida, foi realizada pesquisa qualitativa sobre o estado da arte da ouvidoria no país, com aprofundamento analítico sobre distintos tópicos relativos à participação social, à integridade e à gestão de riscos.



2. Ouvidorias, democracia participativa e as ouvidorias do SUS

Estou convencida de que a solução da maioria dos problemas sociais está relacionada com a redução urgente das desigualdades sociais, a eliminação da corrupção, a promoção da justiça social, o acesso à saúde e à educação de qualidade, ajuda mútua financeira e técnica entre as nações, para a preservação e restauração do meio ambiente.

Zilda Arns (Zilda..., 2016).

Aouvidoria é um instrumento constitucional que tem o condão de identificar, combater, tratar e prevenir as patologias sociais. No Brasil, a prática em ouvidoria se antecipa a muitas legislações que norteiam e normatizam ações voltadas para a integridade das instituições, ou seja, para a garantia e efetividade dos princípios constitucionais que regem a administração pública e para a efetividade e a sustentabilidade das melhores práticas de gestão e transparência.

Servidoras e servidores públicos que atuam em ouvidoria têm uma responsabilidade muito específica, pois o seu fazer diário tem o objetivo de gerar confiança e fomentar entre cidadãos e cidadãs, a oportunidade de conhecer, reconhecer e exigir a prestação dos serviços públicos que estão à sua disposição. Sua função é pública: garantir o acesso à informação certa e, com isso, promover e garantir o acesso a outros direitos fundamentais, como educação, saúde e assistência social.

A eficiência do setor público como um direito difuso da cidadania está consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Brasil, [2023a]), e tal princípio foi inserido no artigo 37 da referida Constituição, com a Emenda Constitucional 19/1998, integrando o rol dos princípios que regem a administração pública.



Fonte: Foto de Joélson Alvez (Agência Brasil).

É a Constituição a principal referência para as normativas que a sucedem no sentido de esmiuçar esse fazer voltado para a garantia de direitos e ela é a referência para análise, interpretação e sistematização das leis infraconstitucionais. A proposta de uma ouvidoria pública, por trabalhar constantemente com a insatisfação humana, é justamente a de transformar a cultura da reclamação em uma cultura de participação, em que prevaleçam o bom senso, o respeito à diversidade, o diálogo, a boa fé e a tolerância entre as partes envolvidas.

O princípio da eficiência está no centro da atuação de uma ouvidoria, conforme disposto na Carta Magna, que estabelece a necessidade de participação popular no acompanhamento da prestação de serviços públicos, abrindo uma possibilidade de se concretizar efetivamente o controle social. Entretanto, a ouvidoria não tem qualquer ingerência nas decisões dos gestores, mesmo porque a ela não cabe decidir. Procura, sim, estabelecer um canal de comunicação que viabilize sempre a oitiva e a interpretação adequada das demandas recebidas, sejam elas da comunidade interna ou externa. É um espaço acolhedor, de conexão, de compreensão, de valorização do ser humano, que busca construir pontes, não muralhas.

Já como recurso de governança, apoiado nos princípios da ética e da transparência, a ouvidoria serve não somente para proteger cidadãos e cidadãs e esclarecê-los sobre direitos e deveres, mas, também, para fomentar o surgimento de uma demanda social: pessoas mais exigentes, mais esclarecidas e mais propositivas, no que se refere à qualidade dos serviços prestados, tendo como contrapartida a oportunidade de melhoria desses serviços.

As manifestações de quem recorre à ouvidoria, independentemente de sua natureza, traduzem-se em sinais de alerta, desafios e reflexões.

A escuta ativa permite à Ouvidoria, a partir do reconhecimento de uma manifestação individual, mapear questões mais amplas, de caráter coletivo, propondo tratamentos e soluções para elas. A escuta ativa abre caminho para a escuta inclusiva. O facilitador do diálogo deve ter em conta que o silêncio tem voz (Riche, 2021, p. 9).

Além disso, o respeito, o diálogo e a tolerância são essenciais para retirar os públicos da condição de demandantes/reclamantes e alçá-los à condição de consultores qualificados das instituições. Esses entendimentos permitem, por parte das ouvidorias, atuar pedagogicamente, para transformar a cultura da reclamação em uma cultura de participação. Ouvidores e ouvidoras atuam para que os momentos de conflitos daqueles que os procuram se traduzam na possibilidade de aperfeiçoamento institucional, em que o diálogo prevaleça, levando em consideração todas as vozes e a relação dialógica.

Embora vetusta, a ouvidoria, como representante do povo, é ainda muito jovem no Brasil (a primeira foi criada em 1986, em Curitiba, com a natureza de representação dos cidadãos, cidadãs e de controle social). Não há dúvidas sobre sua capacidade de gerar inovação social, estimular e fortalecer a participação social, bem como fortalecer as democracias. Inovação social, aqui, deve ser compreendida como uma nova solução para um problema da comunidade ou da sociedade, uma solução mais justa, consensual, eficiente, efetiva e sustentável, comparativamente às soluções anteriormente existentes.

Conforme Brasil (2014), em 1996, a 10ª Conferência Nacional de Saúde deliberou pela criação de ouvidorias do SUS em todos os níveis de gestão. Nesse mesmo ano, a gênese do Departamento de Ouvidoria do SUS se deu como consequência de uma estratégia de enfrentamento da pandemia de aids, por meio de um número de telefone gratuito (0800-612437) colocado à disposição da sociedade para informá-la sobre o HIV e também sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST), no Pergunte Aids. Como resultado do grande volume de ligações recebidas, em 1997 teve início o processo de expansão

do serviço, que se transformou em Disque Saúde, a cargo do Ministério da Saúde, englobando outras doenças, ações e políticas de saúde, conselhos de saúde, transplantes de órgãos, dentre outros itens, além de registrar denúncias, reclamações e sugestões ao Ministério (Brasil, 2014, p. 6).

Essa experiência acumulada possibilitou a parceria com diversas áreas e a criação de outros serviços de atendimento ao cidadão: Disque Pare de Fumar (0800-7037033), Disque Saúde da Mulher (0800-6440803), Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (0800-990500) e Disque Medicamentos (0800-6440644). Em abril de 2002, por meio do Decreto n. 4.194, foi criado o Centro Nacional de Promoção da Qualidade e Proteção aos Usuários do SUS, onde foram agregados todos os serviços de contato com os cidadãos que existiam no Ministério da Saúde (Brasil, 2014, p. 6).

Em 2003, a 12^a Conferência Nacional de Saúde deliberou pela definição e implementação da Política Nacional de Ouvidorias do SUS para as três esferas de governo e, nesse contexto, foi criada no Ministério da Saúde a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP)

[com intuito] de integrar e estimular práticas que ampliassem o acesso dos usuários do SUS ao processo de avaliação das políticas públicas de saúde e, vinculado à SGEP, o **Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS, como exemplo concreto de participação da comunidade e de democratização das informações em saúde, e, consequentemente, da gestão do SUS.**

[...] Em 2011, com vistas à definição da prática de Ouvidoria Ativa, o conceito de ouvidoria sofreu uma mudança em seu paradigma. Nesse novo contexto,

a Ouvidoria do SUS passou também a buscar o usuário do SUS a fim de que avaliasse os serviços ofertados, subsidiando, dessa forma, a implementação das políticas públicas de saúde.

A Ouvidoria Itinerante, uma estratégia de ouvidoria ativa, tem sido um canal transformador de estímulo à participação social, disseminação de informações em saúde, conscientização popular, constituindo-se em instrumento garantidor da democratização e da ampliação dos direitos do cidadão.

Em 2012, o Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS passou a utilizar outros instrumentos de Ouvidoria Ativa: a realização de pesquisas, como a da Rede Cegonha; a coordenação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, de acordo com a Lei de Acesso à Informação; e o envio de cartas aos usuários do SUS (Sistema CartaSUS) para o controle e aferição da qualidade da assistência prestada pelos serviços do SUS.

O DOGES, responsável por formular e coordenar a Política de Ouvidoria para o SUS, possibilitou a criação de diversos espaços de escuta e participação popular (Ouvidorias do SUS) nos estados, no Distrito Federal, nas capitais e em vários municípios do país (Brasil, 2014, p. 6, grifo nosso).

De lá para cá, esse sistema foi aperfeiçoado, inclusive por ordenamentos jurídicos que abarcam não apenas as ações vinculadas ao Ministério da Saúde ou a área de saúde pública em si, mas outras áreas de atuação governamental, de forma a promover mais transparência, diálogo, participação social e acesso da população a informações e serviços, diminuindo a assimetria comunicacional e, conseqüentemente, a assimetria de poder.

Em relação aos serviços, em passado recente, a ligação telefônica era o canal mais usual. Agora os serviços são oferecidos de outras formas, porque foram ampliados os canais, com o uso de computadores e celulares, sites e sistemas de atendimento capazes de gerar grandes bancos de dados para as instituições. E não se pode deixar de destacar, também, o atendimento humanizado, pessoal e presencial no ambiente físico das ouvidorias.

Esses elementos evidenciam que as ouvidorias são instrumentos pelos quais se dá o exercício da autonomia e da responsabilidade cidadã e, por intermédio da participação popular e até mesmo de ofício, são capazes de elaborar diagnósticos de situações, identificando gargalos institucionais e propondo mudanças.

Em diversas partes do mundo (*defensorías del pueblo* na América Latina e Caribe, *ombudsman* na Europa, por exemplo), essas arquiteturas democráticas de participação popular têm um papel de cidadania importante, por se traduzirem, na prática, em um dos instrumentos que viabilizam a transição da “cultura da sentença” para a “cultura da construção de consensos”, entendendo consensos como mecanismos emancipatórios¹.

Para que se instaure um ambiente democrático, duas premissas devem ser levadas em conta: a de que a população deve ser emancipada e a de que ela deve ser participativa. Para tanto, é imprescindível aos ouvidores e ouvidoras promoverem a cidadania ativa. Para colocá-la em prática, é necessário acolhimento, ética, escuta, empatia, compaixão, inclusão, respeito, responsabilidade, valorização recíproca, confiança, tempo, num cenário em que todos são vistos como partícipes.

¹ Para mais informações sobre a atuação contemporânea das *defensorías del pueblo*, ver <https://www.ilo-defensordelpueblo.org/>.

Garantir aos cidadãos e às cidadãs – razão de existir das ouvidorias – o direito à petição, à criação de condições para a efetividade dos direitos fundamentais – tais como o direito à vida, à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à liberdade de expressão, à informação certa e à igualdade, entre outros –, bem como reforçar a primazia do interesse público e a integridade institucional são diretrizes primordiais.

Profissionais das ouvidorias devem exercer as suas ações de forma pedagógica, com serenidade, seriedade, confidencialidade e solidariedade, fortalecendo ao mesmo tempo, a cultura da transparência e a da participação social, com linguagem simples e acessível e adequada ao interlocutor, contribuindo para uma sociedade melhor e mais aberta às demandas que se apresentam no cotidiano.

Caovilla, Boita e Balbinot (2018-2019) afirmam que, especificamente no contexto latino-americano, um grande desafio a ser enfrentado é superar a cultura jurídica ocidental, antropocêntrica, para que se estabeleça, na região, a construção de um “pensamento decolonial”, capaz de produzir conhecimento jurídico a partir das problemáticas do Sul. Caovilla (2016 *apud* Caovilla; Boita; Balbinot, 2018-2019) propõe uma nova concepção de ensino jurídico, “lançando mão de uma educação jurídica para o ‘bem viver’, como estratégia de empoderamento dos indivíduos, especialmente em contextos de exclusão extrema, como vivenciado no Brasil e em toda a América Latina” (Caovilla, 2016 *apud* Caovilla; Boita; Balbinot, 2018-2019, p. 576).

Uma educação plural, intercultural e interdisciplinar à compreensão dos problemas sociais, propõe não somente a emancipação e a autonomia dos indivíduos, visando uma mudança de orientação

epistemológica, de forma a renovar a teoria crítica do Direito com a criação de escolas de Direito, que tenham entre as suas finalidades o enfrentamento dos problemas da sociedade, o reconhecimento às diferenças, à pobreza, à marginalidade, mas também a abertura para inclusão de outras “espécies como sujeitos de direitos” (Caovilla; Boita; Balbinot, 2018-2019, p. 576).

Os autores destacam que as constituições recentes do Equador e da Bolívia são exemplos de instrumentos jurídicos que afirmam a pluralidade da região e incluem o “bem viver” em suas concepções,

sendo ajustável à realidade socioambiental de cada comunidade que compartilhe o propósito de dar voz às culturas silenciadas e criar alternativas às práticas políticas e jurídicas monistas e eurocêntricas que por muito tempo, desde a colonização, predominaram e perpetuaram a colonialidade do ser, do saber e do poder na América Latina (Caovilla; Boita; Balbinot, 2018-2019, p. 572).

No Brasil, um exemplo bem-sucedido no que se refere à elaboração de instrumentos voltados à emancipação dos sujeitos foi a criação das ouvidorias externas nas Defensorias Públicas, com a Lei n. 132/2009, inaugurando uma nova fase da democracia participativa no país, ao incluírem, em sua formação, os movimentos sociais e populares. Com elas, o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas do Brasil assume o compromisso de fortalecer o referencial de direitos humanos no cotidiano das defensorias públicas.

Entre seus objetivos institucionais estão também a promoção e a divulgação de estudos sobre o funcionamento das ouvidorias públicas, a defesa dos princípios, prerrogativas e funções

institucionais da Defensoria Pública, a promoção de estudos e ações que permitam a construção de indicadores de demandas a partir da perspectiva dos usuários e usuárias da defensoria, das prioridades da sociedade civil organizada, entre outros tantos objetivos (Paraná, [20--]).



Fonte: Foto de Fabio de Rodrigues-Pozzebom (Agência Brasil).

Ao falar sobre a escolha dos dirigentes para as ouvidorias, Lyra (2004) defende que elas sejam autônomas. Para o autor,

a concepção de uma ouvidoria autônoma e democrática, sem desconsiderar a importância da qualificação do ouvidor, entende que o cargo não é para ser atribuído a técnicos adestrados ao seu

exercício e sim a “militantes da cidadania” cuja práxis os tenha credenciado junto à sociedade para ser o seu porta-voz (Lyra, 2004, p. 6).

Diante do Estado, devemos reconhecer que os cidadãos e as cidadãs estão em uma posição relativamente vulnerável (técnica, jurídica, econômica e socialmente). Portanto, a luta pela dignidade humana é a razão e a consequência da luta pela democracia e pela justiça. Nesse sentido, o trabalho das ouvidorias é um trabalho de resistência.



3. Como contribuir para que as pessoas tenham acesso à informação?

Ao mesmo tempo que a tristeza, o desânimo, revelam a nossa impotência, nos fazem novamente buscar esse caminho da utopia, do sonho, da luta pela justiça, nos faz compreender que o mundo não está pronto.

Conceição Evaristo (Bernardes, 2021).

Resultados apresentados pela pesquisa Edelman Trust Barometer (Edelman Trust Institute, 2023a) revelam que, no Brasil, empresas e organizações não governamentais (ONG) são consideradas as únicas instituições confiáveis, em contraposição à mídia e aos governos, que entram na categoria da desconfiança e, para além dessa classificação crítica, são vistos como fonte de desinformação (Edelman Trust Institute, 2023a, p.12).

O Relatório Especial Edelman Trust Barometer 2023: Confiança e Saúde (Edelman Trust Institute, 2023b) revelou dados importantes sobre o pensamento dos brasileiros e das brasileiras em relação à saúde, destacando que tais manifestações estão fortemente vinculadas à sensação de polarização social. Na seção “As mudanças no panorama da Saúde” (Edelman Trust Institute, 2023b, p. 3), a pesquisa informa que, em relação aos medos gerados pela economia, a inflação está no topo da lista de fatores da sociedade que estão afetando negativamente a saúde das pessoas e que o custo

e a dificuldade de acesso também ganharam importância como maiores barreiras para o acesso a uma saúde melhor.

Em relação à polarização social, tomando como referência o Relatório Trust Barometer (Edelman Trust Institute, 2023a) relativo ao mesmo ano, a pesquisa destaca que a sensação, entre os brasileiros e as brasileiras, é de falta de confiança no sistema de saúde, uma consequência da sensação de que o próprio sistema social é injusto e de que instituições como a mídia, entre outras, não são confiáveis.

Edelman Trust Institute (2023b) aponta que o presente mostra uma “dispersão de autoridade” porque, apesar de médicos, autoridades governamentais e especialistas em saúde ainda serem vistos como fontes confiáveis de informações sobre saúde, a influência de amigos e familiares tem aumentado em relação ao tema, mesmo que não tenham formação na área. “As pessoas estão mais engajadas com informações sobre saúde e comparando dados de diferentes fontes, além de esperarem um serviço de saúde que as trate de igual para igual”, informa o relatório, ao classificar esse novo perfil como “paciente empoderado” (Edelman Trust Institute, 2023b, p. 3).

Um ponto de destaque é que, segundo a população, está cada vez mais fora de alcance cuidar da própria saúde. Nesse sentido, 54% dos brasileiros e das brasileiras consideram de moderada a extremamente grande a distância entre o quanto estão e o quanto deveriam estar cuidando de si, uma mudança de 14 pontos em relação à pesquisa do ano anterior (Edelman Trust Institute, 2023b, p. 8).

Outros pontos relevantes apontados por Edelman Trust Institute (2023b) mostram que os brasileiros e as brasileiras acreditam que

a saúde vai além da questão física, incluindo a saúde mental: 84% afirmam que saúde mental, saúde física, saúde social e condições de vida em comunidade são componentes que dão a dimensão de sua saúde, e menos de 1% afirma que ser saudável tem a ver apenas com a saúde física (Edelman Trust Institute, 2023b, p. 13).

Esse breve panorama da recente pesquisa fornece *insights* significativos para se pensar o contexto de atuação das ouvidorias em saúde no país: um tempo presente de contestação de instituições antes consideradas sólidas (a pesquisa conclui que os cidadãos e as cidadãs acreditam que os empregadores fazem mais pela saúde que o próprio sistema de saúde e o governo)² e no qual os sinais de desconfiança em relação à mídia e aos profissionais de medicina acendem um alerta em relação ao consumo desenfreado de *fake news* nos últimos anos.

Ou seja, o acesso à informação certa e a conquista da confiança dos cidadãos e das cidadãs por parte das instituições de saúde estão no centro das demandas estratégicas para o trabalho junto aos públicos das ouvidorias, não apenas as de saúde, mas as de todas as áreas.

Atente-se, por exemplo, para o cenário de desinformação em relação a um assunto crucial para famílias e profissionais de saúde: as vacinas. Logo durante a pandemia de covid-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) chamou atenção para a infodemia como emergência de saúde pública.

Conforme declarado pela OMS, o surto de covid-19 e a resposta a ele têm sido acompanhados por uma **enorme infodemia: um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa**. A palavra infodemia se refere a um grande aumento no volume de informações associadas

² Ver Edelman Trust Institute (2023b, p. 19).

a um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com intenção duvidosa. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente, como um vírus (Zarocostas, 2020, p. 676 *apud* Organização Pan-Americana da Saúde, 2020, p. 2).

Além da infodemia, a sociedade é afetada pela desinformação, informação falsa ou imprecisa cuja intenção deliberada é enganar (Organização Pan-Americana da Saúde, 2020, p. 2):

No contexto da pandemia atual, pode afetar profundamente todos os aspectos da vida e, mais especificamente, a saúde mental das pessoas, pois a busca por atualizações sobre a covid-19 na Internet cresceu de 50% a 70% em todas as gerações. Em uma pandemia, a desinformação pode prejudicar a saúde humana. Muitas histórias falsas ou enganosas são inventadas e compartilhadas sem que se verifique a fonte nem a qualidade. Grande parte dessas desinformações se baseia em teorias conspiratórias; algumas inserem elementos dessas teorias em um discurso que parece convencional.

Figura 1 – Infodemia



Fonte: Ilustração de Felipe Teixeira.

A desinformação é caracterizada por interesses comerciais e políticos, conforme alerta a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm), Isabela Ballalai, ao frisar que, quando a campanha de desinformação é combinada com uma baixa percepção de risco das doenças prevenidas pelas vacinas, a hesitação vacinal ganha força, mesmo entre profissionais de saúde (Lisboa, 2023). Combater a desinformação é um dos desafios da sociedade atual, fortemente afetada pela infodemia e por *fake news*.

Sarlet e Molinaro (2014), em um primoroso estudo sobre direito à informação e direito de acesso à informação como direitos fundamentais na Constituição Brasileira, afirmam que, para a liberdade e o direito de acesso à informação seguirem “sendo o farol que sirva para iluminar e tornar transparente os negócios do Estado, necessária a sempre crescente participação da sociedade civil – de uma proativa cidadania”.

De acordo com os autores, a “Liberdade de Informação (*freedom of information*) é um importante vetor do direito de aceder à informação em posse do poder público” (Sarlet-Molinaro, 2014, p. 19). “O **direito à informação** não se confunde com o **direito de acesso à informação**, contudo, no direito de acesso à informação (em especial no que se refere à informação pública) há direito à informação” (Sarlet-Molinaro, 2014, p. 19, grifo nosso). Esse direito, por sua vez, é informado por outros nove princípios internacionalmente aceitos:

Princípio 1. Divulgação Máxima – A legislação sobre liberdade de informação deve ser guiada pelo princípio da máxima divulgação;

Princípio 2. Obrigação de Publicar – Os órgãos públicos devem ter a obrigação de publicar informações essenciais;

Princípio 3. Promoção de um Governo Aberto – Os órgãos públicos precisam promover ativamente a abertura do governo;

Princípio 4. Abrangência Limitada das Exceções – As exceções devem ser clara e estritamente definidas e sujeitas a rigorosos testes de “dano” e “interesse público”;

Princípio 5. Procedimentos que Facilitem o Acesso – Os pedidos de informação devem ser processados com rapidez e justiça, com a possibilidade de exame independente caso haja recusa;

Princípio 6. Custos – As pessoas não devem ser impedidas de fazer pedidos de informação em razão dos altos custos envolvidos;

Princípio 7. Reuniões Abertas – As reuniões de órgãos públicos devem ser abertas ao público;

Princípio 8. A Divulgação Tem Precedência – As leis que não estejam de acordo com o princípio da máxima divulgação devem ser revisadas ou revogadas;

Princípio 9. Proteção para os Denunciantes – Os indivíduos que trazem a público informações sobre atos ilícitos – os denunciantes – precisam ser protegidos (Mendel, 2008 *apud* Sarlet; Molinaro, 2014, p. 20).

Trata-se de mais um dos direitos garantidos pelo arcabouço jurídico em favor da população. Entretanto, na contramão da onda de desinformação, apatia política ou polarização, figuras como profissionais das ouvidorias são cruciais para o desenvolvimento de políticas e programas voltados para resgatar a confiança da população nos aparatos públicos.

Não podemos esperar que os governos mudem por si mesmos. Os ventos da globalização e da modernização não converterão de modo automático burocratas egotistas em servidores abertos e transparentes. O debate público e a ação política são elementos chave na consolidação da 'transparência' (Sarlet; Molinaro, 2014, p. 37).

É relevante destacar como é fundamental a interlocução de ouvidores e ouvidoras com a academia e com os movimentos sociais, com a academia, por exemplo, porque ela pode contribuir na produção de um conhecimento que contemple a necessidade da sociedade; com os movimentos porque estão à frente das demandas mais urgentes para a população.

Este trabalho de promoção da transparência, cada vez mais amplo, demanda refletir, escutar, agir com responsabilidade e conhecimento construído diariamente no fazer da ouvidoria para a criação de um futuro melhor para todas as pessoas. De certa forma, é a utopia se fazendo presente, mas, sem utopia, não há avanços.



4. Como a ouvidoria se insere no contexto da integridade pública e da área de saúde pública?

Precisamos reconhecer a dignidade de todo e qualquer ser humano. Esse é o principal sentido da vida e está ao alcance de todos nós.

Graça Machel (Haddad, 2019).

A integridade pública é um princípio fundamental para o bom funcionamento das instituições governamentais, pois está diretamente ligada a fatores como transparência, eficiência, ética e responsabilidade. A integridade deve estar arraigada na cultura organizacional e, no âmbito do SUS, encontra nas ouvidorias de saúde instrumentos potentes para se efetivar.

De acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), a integridade pública “deve ser entendida como o conjunto de arranjos institucionais que visam fazer com que a Administração Pública não se desvie de seu objetivo principal: entregar os resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial e eficiente” (Brasil, [2019?]).

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define integridade pública como a adesão a valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público. A estratégia de integridade pública proposta pela

OCDE prevê que as políticas adotadas pelos países considerem o contexto em que estão inseridas, os aspectos comportamentais e os riscos aos quais as organizações estão submetidas. Essa estratégia é dividida em três pilares: a construção de um sistema de integridade coerente e abrangente; a promoção de uma cultura de integridade pública e; uma prestação de contas eficaz (Brasil, [2023?]).

Conforme a CGU (Brasil, [2023?]), a corrupção impede que os resultados de integridade sejam atingidos e compromete, em última instância, a própria credibilidade das instituições públicas. De acordo com a Controladoria (Brasil, [2023?]), discutir a integridade de uma organização envolve temas como:

- conduta ética;
- orientações e exemplos das lideranças;
- processos e divisões de trabalho;
- políticas de incentivo a determinados comportamentos;
- sistemas de prestação de contas;
- processos de monitoramento; e
- uso de recursos e as interações com a sociedade em geral.

Assim, a gestão da integridade é considerada componente da boa governança, uma condição que dá às outras atividades de governo legitimidade, confiabilidade e eficiência.

Uma gestão da integridade bem desenvolvida, onde todos os sistemas (correição, controles internos, gestão da ética, dentre outros) são bem coordenados, favorece os agentes públicos a tomarem decisões em função de critérios técnicos, e não com base em interesses particulares, o que, por sua vez, aumenta a qualidade na prestação dos serviços públicos (Brasil, [2023?]).

Por conseguinte, o programa de integridade de uma organização é definido pela CGU como um “conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta” (Brasil, [2019?]), sendo as ouvidorias e os setores de correição alguns dos instrumentos disponíveis para a viabilização do programa, por meio de diretrizes previamente adotadas.

Nesse sentido, os gestores públicos devem estar conscientes de que desenvolver uma política de integridade pública vai além do mero respeito às normas. As medidas de proteção devem ser pensadas e implementadas de acordo com os riscos específicos de cada órgão ou entidade (Brasil, [2019?]).

Importante chamar atenção para o entendimento da integridade como cumprimento de normas. No setor privado, quando o assunto são as práticas anticorrupção, o termo “*compliance*” é comumente utilizado para descrever as melhores práticas de gestão, e existem entendimentos que se cruzam quando se fala em integridade e *compliance*.



Fonte: Foto de Marcelo Camargo (Agência Brasil).

Caldeira e Dufloth (2021) trabalham com uma noção “ampliada” de *compliance*, colocando-a para além da conformidade das companhias privadas com seus regulamentos e normas. “Do ponto de vista prático, a função de *compliance* adquire novas divisas, debruçando-se não só sobre aspectos relativos à conformidade corporativa, como também sobre questões relacionadas à cultura da ética e da integridade” (Caldeira; Dufloth, 2021).

Compliance se aproxima, assim, do conceito de integridade aqui verificado para a administração governamental, entretanto, em relação à integridade na administração pública, Caldeira e Dufloth (2021) analisam diversas concepções que, em comum, indicam o interesse público como ponto central das práticas anticorrupção relativas à integridade:

O conceito de integridade adquire, assim, sob o espectro da Administração Pública, contornos específicos, tendo no centro a noção de interesse público. Sobre isso, a OCDE (2017, p. 7) discorre da seguinte forma: ‘public integrity refers to the consistent alignment of and adherence to, shared ethical values, principles and norms for upholding and prioritising the public interest over private interests in the public sector’³.

De igual modo, poder-se-ia argumentar que, da perspectiva da Administração Pública, um dos objetivos centrais do *compliance* é a prevenção e o combate aos crimes de corrupção, tendo como fim último promover uma melhoria na qualidade de vida da população com a aplicação adequada dos recursos por parte do Estado (Alves; Pinheiro, 2017).

Para a Controladoria-Geral da União (CGU, 2017), o conceito de integridade pública representa um estado ou condição de inteireza e guia uma atuação imaculada, livre de desvios, e norteadada pelo interesse público (Caldeira; Dufloth, 2021).

³ “Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão a valores éticos, princípios e normas compartilhados para defender e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público” (tradução nossa).

Já a concepção de correição, definida, de forma geral, pelos mecanismos de correção e, na administração, pelas funções atribuídas à figura da corregedoria, encontra no poder disciplinar o campo para sua execução, conforme Brasil (2022):

a) para Hely Lopes Meirelles, o poder disciplinar seria ‘a faculdade de punir internamente as infrações disciplinares dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração Pública’;

b) para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder disciplinar ‘é o que cabe à Administração Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa’;

c) para Marcello Caetano, o ‘Poder Disciplinar tem origem e razão de ser no interesse e na necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público’.

Brasil (2022) descreve que a correição é uma das áreas fundamentais de atuação da CGU e que consiste nas atividades relacionadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores e empregados públicos e à aplicação das devidas penalidades:

Alguns órgãos e entidades da Administração Pública Federal dispõem [de unidade especializada em matéria disciplinar], por norma específica (seja lei orgânica, estatuto ou regimento interno), de unidade especializada na matéria disciplinar, normalmente chamada de Corregedoria, dotada de competência exclusiva para o assunto. No entanto, em outros órgãos e entidades, não há uma estrutura de Corregedoria e tal atribuição é desempenhada por algum setor administrativo (Brasil, 2022).

Schirato ([2015], p. 22) aponta que as correições “são desempenhadas por órgãos autônomos da Administração Pública destinados a corrigir ações eivadas de vícios detectadas por ação *ex officio* ou por provocação de terceiros, internos ou externos à autoridade”.

O clássico cartaz, bastante comum nas repartições, informa que a ouvidoria serve para o público fazer elogios, reclamações e sugestões. Mas esse recado pode se estender para estruturados planejamentos de gestão e de comunicação que, integrados com outros setores dos órgãos em que atuam, incluem, por exemplo, ações de relações públicas para melhorar a comunicação com as pessoas que usam serviços e, em relação aos públicos internos, ações de *endomarketing*⁴ e treinamentos sobre liderança e gestão de crises. Isso porque a ouvidoria além de desenvolver relações interdependentes com os vários setores da instituição, deve ter um olhar e uma atuação multidisciplinar que se apoiem em várias áreas do conhecimento, para melhor servir o seu público.

Como ferramenta que identifica problemas e sugere melhorias para os fluxos e para a gestão interna, em especial para a administração executiva, a ouvidoria em saúde pode avaliar o desempenho dos serviços públicos, na medida em que atua como um canal de comunicação entre cidadãos, cidadãs e a administração, demonstrando, assim, a capacidade privilegiada de fornecer *feedbacks* contínuos para ambas as partes.

No apoio à criação da cultura corporativa, a ouvidoria pode desempenhar um papel pedagógico, proporcionando treinamento para os servidores, formando o corpo social habilitado à execução de práticas antidiscriminatórias, à promoção de igualdade e outras demandas urgentes do século 21, e garantindo que as equipes estejam capacitadas para lidar com questões sensíveis e para promover

⁴ Ressaltamos que a ouvidoria não deve ser responsável pelo marketing da organização. Ela pode prover informações para as campanhas de comunicação, além de acompanhá-las e avaliá-las com base nos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé.

ambientes de trabalho inclusivos, livres de violência e de diferentes tipos de assédio.

A ouvidoria no âmbito do SUS, ao atender a uma demanda individual, e conhecendo a solução para um determinado problema, tem capacidade de recomendar à administração que a medida seja adotada de forma ampla para prevenir que outros cidadãos e cidadãs venham a se deparar com o mesmo problema, fomentando, assim, a eficiência institucional.

Ao recomendar internamente adoção da transparência pública, por meio de ofícios de recomendações, memorandos atinentes ao conhecimento e cumprimento de leis, manuais, campanhas internas e outras comunicações, a ouvidoria contribui para a prevenção de práticas corruptas.

Transparência Internacional (2022), em “Recomendações de Transparência e Governança Pública para Prefeituras”, reúne exemplos de suma importância de princípios, obrigações legais, recomendações e boas práticas para apoiar o fortalecimento da integridade, transparência e participação cidadã nas administrações públicas de municípios brasileiros de médio e pequeno portes.

A transparência pública é um elemento basilar para a democracia e um dos modos mais eficazes para prevenir e combater a corrupção, ainda mais eficiente quando aliada a mecanismos de governança pública e integridade.

A evolução de tecnologias, suas ferramentas, princípios e prerrogativas legais aumentam as condições necessárias para que órgãos públicos promovam mais transparência, aprimorem sua governança pública, e fomentem a participação social (Transparência Internacional, 2022, p. 3).

Figura 2 – Fluxograma de fomento à eficiência institucional por meio da ouvidoria



Fonte: Ilustração de Felipe Teixeira.

Na seção dedicada exclusivamente às recomendações para a área de saúde, o organismo apresenta cinco recomendações sobre o uso de plataformas para a promoção de transparência (Transparência Internacional, 2022, p. 20):

- Destaque ao Portal de Transparência e Sistema e-SIC no site da Secretaria de Saúde;
- Divulgação de conjuntos de dados no Portal de Dados Abertos;
- Ferramenta de acessibilidade no site da Secretaria de Saúde;
- Canal para agendamento de consultas, exames e demais serviços de saúde;
- Canal de Ouvidoria da Saúde/SUS e respectivo relatório.

Em relação à transparência administrativa e governança, Transparência Internacional (2022, p. 22-23) defende como imprescindíveis a regulamentação da atuação do Conselho Municipal de Saúde, a divulgação do Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação ou Plano Anual de Saúde (PAS) e a divulgação do Relatório Anual de Gestão (RAG). Como medidas altamente recomendáveis, o organismo recomenda a “divulgação de forma acessível, e com destaque, do Código de Conduta ou de Ética no site da Secretaria de Saúde” e a publicidade dos relatórios de auditoria interna. Recomenda, ainda, a existência de comissão/comitê/grupo de trabalho interno à secretaria de saúde para ações de controle interno.

O documento também faz recomendações para ações relacionadas a transparência e abertura de dados, comunicação, participação e engajamento social, consistindo em rico material de pesquisa para profissionais que atuam em ouvidorias de saúde nas redes estadual e municipal.



5. Arcabouço da normativa brasileira com aplicação nas ouvidorias; principais diretrizes das normativas em ouvidoria

Temos de democratizar o sistema internacional de saúde, para que as vozes dos Estados e de suas populações, sobretudo as negligenciadas, possam ser ouvidas.

Nísia Trindade (2023).

As ouvidorias públicas desempenham um papel fundamental na promoção e garantia dos direitos individuais e sociais no Brasil, respaldadas principalmente pela Constituição Federal de 1988. São vários os dispositivos constitucionais que garantem o acesso a direitos como o de informação, acesso à saúde, à educação, à justiça, que compõem o fazer em uma ouvidoria de saúde.

Como diz Lenio Streck (2019), é fundamental compreender o papel da Constituição. Segundo o professor, a Constituição de 1988 é a mais humanista, mais “garantista” e mais social do mundo e, para ele, o mundo do segundo pós-guerra não conseguiu fazer uma Constituição igual à nossa. O erro quanto à não aplicação de direitos não estaria na Constituinte, nem na Constituição, mas sim na aplicação.

Parece que nós não compreendemos bem o papel da Constituição. Temos uma Constituição com todas as condições de estabelecer o Estado social, diminuição da pobreza, tributação progressiva onde quem ganha mais paga mais e outras questões que estão no seu artigo terceiro. O que nos interessa, fundamentalmente, neste momento de crise é a questão das garantias, dos direitos, das garantias processuais, envolvendo aí os artigos quinto e sexto. Os ataques à Constituição vêm de todos os lados: reforma previdenciária, reforma trabalhista, venda de patrimônio público, retirando as condições de o Estado acumular para distribuir, numa perspectiva de Estado social, além dos ataques às liberdades (Streck, 2019).

Por si só, a Constituição Federal (Brasil, [2023a]) já confere forte aparato legal para profissionais de ouvidoria. Pode-se afirmar que o artigo 37, especificamente no parágrafo 3º, incisos I, II, III, viabiliza o exercício da cidadania ativa, que se traduz na capacidade de as pessoas se manifestarem, pedirem informação e expressarem seu direito ao requerimento de informações públicas.

O arcabouço que favorece as medidas para promoção de integridade e correição, no âmbito da administração pública, é muito amplo. A seleção a seguir elenca os principais referenciais à disposição da ouvidoria que atua na área de saúde, pensando sua articulação e interface com departamentos de diferentes áreas, seja na Atenção Primária à Saúde, na Atenção Especializada ou na Alta Complexidade.

Quadro 1 – Principais referenciais à disposição da ouvidoria na área de saúde

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Preâmbulo. Institui um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Dos princípios materiais estruturantes e os fundamentos republicanos. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

- I - a soberania;
- II - a cidadania;
- III - a dignidade da pessoa humana;
- IV - os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa;
- V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.

Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º, XXXIII). Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Dos direitos sociais (Art. 6º). São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária

Da Administração Pública (Art. 37). A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998) (Vide Lei n. 12.527, de 2011)

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998).

Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Decreto n. 1.171, de 22 de junho de 1994

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

Lei n. 9.265, de 12 de fevereiro de 1996

Regulamenta o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição, dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania.

Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 1997

Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do *habeas data*.

Lei n. 10.741, de 1 de outubro de 2003

Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências.

Portaria GM/MS n. 198/GM/MS, de 13 de fevereiro de 2004

Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências.

Lei n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Portaria GM/MS n. 399 do Ministério da Saúde, de 22 de fevereiro de 2006

Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto.

Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006

Lei Maria da Penha. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.

Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI)

A LAI inseriu no Brasil uma mudança cultural, fazendo do acesso à informação uma regra, e não uma exceção. O artigo 8º, que trata da transparência ativa, foi uma verdadeira inovação, ao determinar que é dever dos órgãos e entidades públicas promover,

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012

O decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na LAI.

Portaria n. 2.761, de 16 de novembro de 2013

Institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS).

Decreto n 13.185, de 6 de novembro de 2015

Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (*bullying*).

Decreto n. 8.777, de 11 de maio de 2016

Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.

Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017

Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição Federal.

Decreto n. 9.094, de 17 de julho de 2017

Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, institui o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de benefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento

de firma e da autenticação em documentos produzidos no país e institui a Carta de Serviços ao Usuário.

Decreto n. 11.529, de 22 de novembro de 2017

Considerado um marco para a integridade na administração pública, o decreto dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Considera a governança pública como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Define como valor público os produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização, que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos.

Inclui a gestão de riscos como um de seus componentes e a define como processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, contemplando as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização. Destina-se a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.

Os planos de integridade são fundamentais para garantir que a administração pública atue de maneira ética, transparente e eficiente, promovendo a proteção do bem público e evitando práticas corruptas.

Instrução Normativa Conjunta n. 1, de 12 de janeiro de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e Transparência e Controladoria-Geral da União

Art 1º. Estabelece os procedimentos relativos às solicitações de simplificação de serviços públicos, a serem efetivadas por meio de formulário denominado “Simplifique!”, com a finalidade de promover a participação do usuário de serviços públicos nos processos de simplificação e desburocratização de serviços, nos termos do art. 13 do Decreto n. 9.094, de 17 de julho de 2017.

Parágrafo único. O formulário a que se refere o *caput* deverá receber reclamações, denúncias e solicitações relativas à simplificação de serviços públicos, que serão tratadas no âmbito do Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv).

Decreto n. 13.709, de 14 de agosto de 2018

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Decreto n. 9.492, de 5 de setembro de 2018

Regulamenta a Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, e altera o Decreto n. 8.910, de 22 de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

Decreto n. 10.153, de 3 de dezembro de 2019

Dispõe sobre as salvaguardas de proteção à identidade dos denunciante de ilícitos e de irregularidades praticados contra a administração pública federal direta e indireta e altera o Decreto n. 9.492, de 5 de setembro de 2018.

Decreto n. 10.228, de 5 de fevereiro de 2020

Altera o Decreto n. 9.492, de 5 de setembro de 2018, que regulamenta a Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017, para dispor sobre o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal e instituir os conselhos de usuários dos serviços públicos no âmbito da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo federal.

Instrução Normativa n. 55, de 20 de julho de 2020

Altera a Instrução Normativa Conjunta n. 1, de 12 de janeiro de 2018, dos Ministros de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Transparência e Controladoria-Geral da União, que dispõe sobre os procedimentos aplicáveis à Solicitação de Simplificação de que trata o Decreto n. 9.094, de 17 de julho de 2017.

Decreto n. 10.890, de 9 de dezembro de 2021

Altera o Decreto n. 9.492, de 5 de setembro de 2018, e o Decreto n. 10.153, de 3 de dezembro de 2019, para dispor sobre a proteção ao denunciante de ilícitos e de irregularidades praticados contra a administração pública federal direta e indireta.

Portaria n. 581, de 9 de março de 2021, da Controladoria-Geral da União

Estabelece orientações para o exercício das atividades de ouvidoria desenvolvidas pelas unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (SisOuv) de que trata o Decreto n. 9.492, de 5 de setembro de 2018, bem como dispõe sobre o

recebimento do relato de irregularidades de que trata o *caput* do art. 4º-A da Lei n. 13.608, de 10 de janeiro de 2018, no âmbito do Poder Executivo federal.

O disposto nesta Portaria aplica-se aos órgãos e entidades que integram o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (SisOuv), sendo que os artigos 84 a 88 também se aplicam aos órgãos e entidades que integram o Sistema de Correição do Poder Executivo federal de que trata o Decreto n. 5.480, de 30 de junho de 2005.

Decreto n. 11.529, de 16 de maio de 2023

Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal.

Decreto n. 11.528, de 16 de maio de 2023

Institui o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, ligado à CGU, com objetivo de sugerir medidas de aperfeiçoamento e fomento de políticas e estratégias sobre combate à corrupção e de realizar o acompanhamento e fiscalização da aplicação de recursos públicos, governo aberto, transparência e acesso à informação pública, e integridades pública e privada.

Fonte: Elaboração da autora.

Conforme Riche (2011), as ouvidorias são direitos de quarta geração, direito de solidariedade e de fraternidade, com a função pública de promover o acesso à informação, como dever do Estado, e de prevenir os conflitos de ordem administrativa e jurídica.

Em relação ao reconhecimento internacional em torno da relevância das ouvidorias para promoção e consolidação da

democracia, é importante destacar que a Resolução n. 75/186 de 16/12/2020 divulgada pela ONU durante a 46ª sessão plenária de sua Assembleia-Geral é um marco social (Organização das Nações Unidas, 2020). Isso significa que ouvidorias, *defensorías del pueblo*, *provedorias de justiça* e profissionais de mediação ganharam reforço institucional das Nações Unidas, pois evidenciam e estimulam medidas de protagonismo para a defesa de direitos, para a promoção da boa governança e dos estados democráticos. O documento incentiva fortemente os estados-membros a adotarem diversas medidas, entre elas:

- considerar a criação ou o fortalecimento de organizações independentes, provedoras de justiça e de instituições mediadoras em nível nacional e, onde aplicável, em nível regional ou local;
- realizar atividades de conscientização sobre seus papéis e funções;
- garantir que as ouvidorias públicas tenham as ferramentas necessárias para resolver casos de má administração, investigar e comunicar resultados;
- apoiar as ouvidorias para que tenham exercícios independentes, com mecanismos de promoção e proteção dos direitos humanos, boa governança e respeito pelo Estado de Direito⁵.

Em maio de 2024, outro fato importante contribuiu para revigorar a democracia participativa no Brasil: a 77ª Assembleia Mundial da Saúde aprovou por consenso uma resolução inédita que legitima a Participação Social em Saúde. Com a incidência do Conselho Nacional de Saúde (CNS) brasileiro para a aprovação, o documento determina que a sociedade civil influencie na tomada de decisões em todo ciclo das políticas públicas de saúde, de forma transparente, em todos os níveis

⁵ Cf. Organização das Nações Unidas (2020, tradução nossa).

dos sistemas de saúde. Segundo o CNS, com a aprovação dessa resolução, o Controle Social do Brasil se torna referência para todo o mundo, pelo acúmulo histórico sobre o tema, e pela incidência do conselho na construção do texto aprovado (Conselho Nacional de Saúde, 2024).

Como bem destaca Dallari (1996), hoje há certos direitos que nem as leis nem as autoridades públicas podem contrariar. Eles estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas, em 1948. A declaração proclama a promoção do respeito aos direitos e liberdades nela previstos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o esforço de cada indivíduo e cada órgão da sociedade por meio do ensino e da educação. A declaração ainda proclama a adoção

de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição (Organização das Nações Unidas, 1948).

Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todas as pessoas, regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. O UNICEF ([2019]) caracteriza os direitos humanos da seguinte forma:

Universalidade e inalienabilidade

Os direitos humanos são universais e inalienáveis. Todas as pessoas em todo o mundo têm direito a eles. Ninguém pode voluntariamente desistir deles. Nem outros podem tirá-los dele ou dela.

Indivisibilidade

Direitos humanos são indivisíveis. Sejam de natureza civil, política, econômica, social ou cultural, eles são todos inerentes à dignidade de toda pessoa humana. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor como direitos. Não existe um direito ‘menor’. Não há hierarquia de direitos humanos.

Interdependência e inter-relação

A realização de um direito muitas vezes depende, no todo ou em parte, da realização de outros. Por exemplo, a realização do direito à saúde pode depender da realização do direito à educação ou do direito à informação.

Igualdade e não discriminação

Todos os indivíduos são iguais como seres humanos e em virtude da inerente dignidade de cada pessoa humana. Todos os seres humanos têm direito a seus direitos humanos sem discriminação de qualquer tipo, como raça, cor, sexo, etnia, idade, idioma, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, deficiência, propriedade, nascimento ou outro *status* como explicado pelos órgãos dos tratados de direitos humanos.



Fonte: Foto de Julia Prado (Ministério da Saúde).

Participação e inclusão

Cada pessoa e todos os povos têm direito à participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento civil, político, econômico, social e cultural, por meio do qual os direitos humanos e as liberdades fundamentais podem ser realizados. Têm também direito a contribuir para esse desenvolvimento e a desfrutar dele.

Responsabilização e Estado de Direito

Os Estados e outros detentores de deveres têm de cumprir as normas e padrões legais consagrados nos instrumentos de direitos humanos. Quando não o fizerem, os titulares de direitos lesados têm o direito de instaurar procedimentos para uma reparação adequada perante um tribunal competente ou outro adjudicador, de acordo com as regras e procedimentos previstos na lei (UNICEF, 2019).

Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de uma pessoa.



6. Boas práticas de ouvidorias implementadas no âmbito do SUS

Será preciso constância, paciência e um ambiente livre de qualquer coação para que relações de amizade e de compreensão possam ser criadas. Sem a ponte desse relacionamento, a cura será quase impossível.

Nise da Silveira (2017, p. 86 *apud* Oliveira, 2020, p. 57).

O trabalho em ouvidoria requer habilidades técnicas e emocionais das pessoas que ali atuam, mas não exige que se invente a roda. Apesar de o mundo encontrar-se no auge da comunicação digital, os métodos analógicos e presenciais são eficientes, práticos e, muitas vezes, de baixo custo: o car-taz na sala de espera, a caixinha de sugestões, o atendimento com diálogo e escuta empática.

O Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) promoveram, em 2012, a primeira edição do Prêmio Cecília Donnangelo de Ouvidoria SUS (Brasil; Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2014), com objetivo de premiar experiências bem-sucedidas em ouvidorias do Sistema. A iniciativa atendeu às deliberações da 14^a Conferência Nacional de Saúde, em especial a de ampliar e consolidar o modelo democrático de governo do SUS.

Foi, também, uma homenagem à sanitarista Maria Cecília Ferro Donnangelo (1940-1983), uma das pioneiras na construção de um pensamento social em saúde.



Fonte: Foto de Marcelo Casal (Agência Brasil).

Outro objetivo da iniciativa foi reconhecer, promover e premiar iniciativas de ouvidorias do SUS, considerando a importância de criar dispositivos que contribuíssem para a implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa (ParticipaSUS). O prêmio foi organizado em duas categorias: “Narrativas e Relatos” e “Pesquisas e Sistematizações”.

Os três casos a seguir estão entre os premiados e fornecem importantes exemplos de boas práticas.

Ouvidoria itinerante como instrumento de gestão

Ouvidoria do SUS de Caruaru (PE)

Em 2012, a Ouvidoria do SUS de Caruaru adotou a estratégia de ir até os usuários e usuárias de serviços de saúde e realizou entre eles, e também entre profissionais, uma pesquisa de satisfação que ouviu 780 pessoas. “Essa forma de ouvidoria representa comodidade para o usuário, já que ele pode realizar sua manifestação sem ter que se locomover até o Departamento de Ouvidoria ou mesmo realizar ligação telefônica”, explicou Karla Simone de Andrade Alves (Brasil, 2014, p. 36), autora do trabalho. Por meio de dois modelos de questionários, um direcionado às pessoas atendidas e outro aos servidores e servidoras da unidade, a pesquisa durou um mês, nas principais unidades de saúde do município de Caruaru, entre elas a Unidade de Saúde da Família, Centros de Saúde, Policlínicas e Hospitais.

Entre os principais pontos levantados pelas pessoas ouvidas estavam: dificuldade nas marcações de consulta, mau atendimento de servidores, falta de medicação ou de profissionais. Entre os elogios, “significativa satisfação quanto à existência da unidade especializada no atendimento da saúde feminina, a Clínica da Mulher” (Brasil, 2014, p. 39). Os resultados foram apresentados às diretorias da Secretaria Municipal de Saúde.⁶

⁶ Ver Brasil (2013, p. 35-41).

Busca ativa para incentivar a democracia participativa

Ouvidoria do Hospital Estadual Eduardo Rabello (HEER), Rio de Janeiro (RJ)

Ao diagnosticar que era preciso se fazer mais conhecida tanto entre o público externo como entre os gestores, o setor adotou a estratégia de ampliar a divulgação sobre seu papel e aumentou o número de urnas para recebimento de comunicações de duas para cinco. Para dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido, foram colocados à disposição impressos e fôlderes com o fluxograma de atendimento, o objetivo da ouvidoria, o que competia ou não ao setor, as formas de acesso aos seus serviços, o que levou ao aumento no acesso por parte dos usuários internos e externos.

A ouvidoria também participou das reuniões de acompanhantes, integrando a equipe multiprofissional (enfermeiro, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, assistente social, direção técnica do hospital e recepção) responsável pela coordenação do projeto, considerado um canal de busca ativa de demandas dos usuários, assim como fonte de mediação de conflitos. A produção de relatórios para gestores entrou na rotina e, entre 2009 e 2012, o número de atendimentos triplicou (Brasil, 2014, p. 79).

A ouvidoria no processo de aquisição de medicamentos

Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa)

Ao atuar não apenas como orientadora sobre os fluxos para aquisição, mas também como canal de entrada dos processos de solicitação de medicamentos, a ouvidoria sistematizou as principais causas relacionadas à dificuldade de acesso dos usuários aos medicamentos essenciais disponibilizados pelo SUS no estado do Pará. O setor concluiu que as dificuldades apontadas poderiam ser contornadas mediante melhoria da gestão dos processos, que levasse em conta a demora na reposição, a demora no processo licitatório, pendências financeiras com fornecedores e os fluxos e processos internos, entre outras questões (Brasil, 2014, p. 57-63).



7. Atuação das ouvidorias do SUS no Brasil

[...] ciência 'não é uma abstração', mas algo concreto, que impacta a vida das pessoas, feita por gente de carne e osso.

Margareth Dalcolmo (2023).

Em 2023 completaram-se duas décadas de criação da então Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, que foi reestruturada pelo Decreto n. 5.841, de 13 de julho de 2006, quando passou a ser denominada Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP). O objetivo da primeira formação da Secretaria era reunir diversas estruturas responsáveis pelas funções de apoio à gestão estratégica e participativa no SUS. Em seguida, conforme relata José Gomes Temporão, incorporou-se à SGEP o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS):

foi instituído o Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, transformou-se o Departamento de Acompanhamento da Reforma Sanitária em Departamento de Apoio à Gestão Participativa e, por fim, ampliou-se o Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS (Brasil, 2009).

No cenário complexo das estruturas governamentais, as ouvidorias desempenham um papel crucial na promoção da transparência, da participação cidadã e no fortalecimento da democracia. Contudo, a efetividade desses mecanismos está intrinsecamente ligada à continuidade e estabilidade das

políticas públicas, que devem ser de Estado, e do apoio destinado à sua estruturação.

Quando há descontinuidade ou hiatos nos instrumentos de participação social, a sociedade perde não apenas uma ferramenta valiosa de participação, mas também a oportunidade de vivenciar avanços tangíveis. No Brasil, especialmente entre os anos de 2019 e 2022, observou-se um desmonte significativo dos conselhos de participação popular, o que resultou em um enfraquecimento preocupante da democracia. Por meio de decreto, a SGEF foi extinta em 2019 (Antunes, 2019).

Um relatório do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebap) revelou que o governo Bolsonaro extinguiu ou esvaziou 75% dos conselhos e comitês nacionais mais importantes do Brasil. Os órgãos acolhiam representantes da sociedade civil para amparar iniciativas do governo e o desmonte da participação popular nas discussões sobre políticas públicas foi alvo de um dos primeiros decretos do ex-presidente (Jornal Nacional, 2021):

Os conselhos ou comitês são formados principalmente por representantes da sociedade e muitas vezes são a única forma de participação popular nas discussões do governo para decidir políticas públicas que vão afetar a todos nós, na saúde, na educação, na defesa dos direitos humanos, no meio ambiente.

O Conama, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, discute as principais políticas ambientais para o país. Integrantes de vários setores participavam das reuniões, mas isso mudou logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Um decreto do presidente, de 2019, permitiu extinguir ou mudar as regras de funcionamento de todos

os conselhos. Ex-conselheiros dizem que cientistas, indígenas e trabalhadores rurais foram excluídos do Conama na nova formação, o que fez a sociedade perder voz no conselho.

[...] O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, um dos símbolos da luta contra a pobreza e a fome, está inativo. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi esvaziado. O Cebrap analisou 100 conselhos e comitês.

[...] ‘Toda montagem que veio sendo feita nos últimos 30 anos da participação social na forma de conselho, ela vai ser exatamente atacada nesse sentido. Então, não há dúvida que quanto menos participação social, menos transparência, mais possibilidade de que o governo tenha todo o controle daquilo que ocorre nas políticas públicas. E isso é o fundamento exatamente do que é o contrário do que a Constituição de 88 preconiza’, afirma o cientista político Wagner Romão, da Unicamp.

Como consequência, a conjuntura foi, automaticamente, de atraso no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas que poderiam ter sido aprimoradas com a colaboração direta da sociedade. A questão da participação popular não foi diferente no que se refere ao âmbito do SUS, com o complicador das graves consequências sociais provocadas pela pandemia de covid-19, que desestabilizou pessoas e instituições, e culminou com uma catástrofe humanitária marcada por mais de 700 mil mortes no Brasil (Covid, 2023).

O desamparo político e estrutural por parte do Governo Federal, naquele período, estendeu-se às ouvidorias de saúde: no âmbito do apoio institucional, no fomento à sua estruturação e desenvolvimento, no apoio à formação e capacitação

de pessoal, nas iniciativas de formação em âmbito nacional, nos eventos e reconhecimento público às boas práticas.

Passados esses quatro anos, é preciso correr contra o tempo para adequar as estruturas da administração pública como um todo às demandas sociais. Segundo Maltchik (2023), atualmente, o Governo Federal conta com ouvidores e ouvidoras em 319 órgãos das administrações direta e indireta; e três seminários sobre o tema ouvidoria foram realizados em 2023 pelo Governo Federal, com outro evento previsto para dezembro, direcionado especificamente ao Sistema Federal de Ouvidorias. Apenas em 2023, de janeiro a 9 de outubro, o sistema federal teria registro de 808 mil manifestações advindas, principalmente, da plataforma Fala.Br. Mais da metade (54,9%) composta por reclamações, seguidas de solicitações (27%) e denúncias (5,5%):

Ocorre que os números só contam uma parte da história. Eles dizem, por exemplo, que o INSS é o principal foco de reclamação, com a expressiva maioria das manifestações que abastecem o painel ‘Resolveu?’, onde estão as informações levadas às ouvidorias.

Porém, os números, sozinhos, não permitem que esses achados sejam analisados e, eventualmente, corrigidos. Para que isso aconteça, o primeiro passo, na avaliação da Ouvidora-Geral da União, Ariana Frances, é fazer com que a ouvidoria se transforme em um espaço de governança de serviços, digitais ou presenciais.

‘A gente está tentando levar repertório de desenho de serviço público para os ouvidores de forma que as ouvidorias não sejam só um balcão. Para dar uma boa informação para o gestor, ele depende de uma unidade de ouvidoria bem capacitada’, explica Ariana Frances (Maltchick, 2023).

Segundo Ariana Frances (Maltchik, 2023), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) será protagonista de um projeto-piloto para a construção de uma metodologia de avaliação de serviços públicos baseada em dados de ouvidoria. Os resultados do experimento deverão ser conhecidos até o final do primeiro trimestre de 2024 e o piloto, com estudo de campo, envolve processo colaborativo, com metodologia de *design thinking* como uma das adotadas para, posteriormente, gerar uma “caixa de ferramentas” para profissionais de ouvidoria.

Hoje, a atual gestão das ouvidorias do SUS desenvolve um estudo com foco na elaboração de um diagnóstico situacional que possa subsidiar a tomada de decisões para o desenvolvimento de novas ações estratégicas de qualificação e fortalecimento das ouvidorias que compõem o sistema. A fragilidade quanto à disponibilidade histórica de dados quantitativos e analíticos mais detalhados sobre o funcionamento da rede de ouvidorias do SUS no Brasil é um dos pontos identificados.⁷

Também estão em desenvolvimento, na Ouvidoria-Geral do SUS (OuvSUS), ações para o fortalecimento das ouvidorias do SUS descentralizadas,

a partir da retomada do apoio técnico, interlocução e diálogo com os gestores do SUS nos estados e municípios. Ressalta-se o desenvolvimento de ações de qualificação profissional e de apoio à implantação do sistema informatizado OuvidorSUS, sobretudo relacionadas à nova versão do sistema [...], além das ações em andamento para a implantação da nova Central de Teleatendimento do Disque Saúde – 136, com processo licitatório em execução.⁸

⁷ Informações concedidas a este estudo por e-mail em 10 de outubro de 2023, por meio da Coordenação de Atendimento ao Cidadão – COACI/Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (OuvSUS).

⁸ *Ibid.*

Para que as ouvidorias do SUS atinjam seu pleno potencial, é imperativo estabelecer uma política governamental robusta que enfrente desafios como a fragmentação do sistema, promova a troca de experiências entre profissionais e assegure o registro e a preservação da memória dos diferentes trabalhos em desenvolvimento.

Figura 3 – Distribuição das ouvidorias estaduais e municipais por região



Fonte: Ilustração de Felipe Teixeira, com base em informações da Coordenação de Atendimento ao Cidadão (2023).

A troca de experiências não apenas contribui para a otimização dos serviços de saúde, mas também cria uma base de conhecimento compartilhada, em que as boas práticas podem ser disseminadas e os desafios enfrentados por uma ouvidoria podem encontrar soluções já testadas por outras. E esse tipo de iniciativa pode ter como um dos seus principais objetivos a promoção da integridade institucional.

De acordo com os dados informados pela OuvSUS para este relatório, atualmente, 1.163 ouvidorias utilizam o sistema OuvidorSUS e cadastram manifestações de assuntos diversos, com 13.326 pontos de respostas (locais que respondem às demandas de ouvidoria).

As tabelas a seguir descrevem a esfera de atuação dessas ouvidorias e pontos de respostas, com os respectivos quantitativos de localidades.⁹

Tabela 1 – Esfera de atuação das ouvidorias que utilizam o sistema OuvidorSUS

ESFERA	OUVIDORIA	PONTO DE RESPOSTA	TOTAL
ESTADUAL	338	2.955	3.293
FEDERAL	10	253	263
MUNICIPAL	815	10.118	10.933
TOTAL GERAL	1.163	13.326	14.489

Fonte: Coordenação de Atendimento ao Cidadão (2023).

⁹ Informações concedidas a este estudo por e-mail em 10 de outubro de 2023, por meio da Coordenação de Atendimento ao Cidadão – COACI/Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (OuvSUS).

Tabela 2 – Descrição das unidades federativas com o respectivo quantitativo de ouvidorias que utilizam o OuvidorSUS (continua)

UF	ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
AC	1		2	3
AL	5		20	25
AM	14		5	19
AP	1		1	2
BA	63		63	126
CE	2		73	75
DF	1	1		2
ES	3		14	17
GO	32		28	60
MA	1		7	8
MG	54		97	151
MS	1		45	46
MT	1		46	47
PA	33		77	110
PB	4		13	17
PE	17		43	60
PI	6		6	12
PR	1		17	18
RJ	28	9	37	74
RN	1		8	9
RO	1		2	3
RR	2		6	8

Fonte: Coordenação de Atendimento ao Cidadão (2023).

Tabela 2 – Descrição das unidades federativas com o respectivo quantitativo de ouvidorias que utilizam o OuvidorSUS (conclusão)

UF	ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
RS	23		29	52
SC	1		20	21
SE	4		6	10
SP	20		128	148
TO	18		22	40
TOTAL GERAL	338	10	815	1.163

Fonte: Coordenação de Atendimento ao Cidadão (2023).

Tabela 3 – Tipos de ouvidorias que utilizam o OuvSUS

TIPO	ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
HOSPITAL	183	9	54	246
REGIONAL	97	-	3	100
SECRETARIA	58	-	758	816
OUVSUS	-	1	-	1
TOTAL GERAL	338	10	815	1.163

Fonte: Coordenação de Atendimento ao Cidadão (2023).

É crucial conhecer a estrutura dessas 1.163 ouvidorias e dos 13.326 pontos de respostas, suas demandas em termos de integração com as redes de ouvidorias, formação continuada, infraestrutura, partilha de conhecimentos produzidos, comunicação, melhoria do atendimento e integridade institucional.

Figura 4 – Distribuição das ouvidorias estaduais, municipais e federais que utilizam o Sistema OuvSUS



Fonte: Ilustração de Felipe Teixeira, com base em informações da Coordenação de Atendimento ao Cidadão (2023).

Para conhecer essas estruturas, neste momento, uma série de questões se colocam para a elaboração de um mapeamento preciso sobre a sua capacidade para trabalhar a integridade nas esferas estadual e municipal, e sobre como as estruturas do Poder Executivo podem apoiá-las:

- Qual é a relevância da ouvidoria para os processos realizados pelos gestores de serviços na instituição? Com qual frequência o ouvidor se reúne com o dirigente máximo da instituição? Há previsão de alocação orçamentária nos planos internos do órgão ou há previsão orçamentária específica para a realização das ações de ouvidoria? A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? Como e quando a ouvidoria transmite as informações analisadas aos gestores de serviços e ao nível estratégico?¹⁰
- Qual a formação profissional das ouvidoras e dos ouvidores que atuam no SUS?
- A formação continuada dos servidores e servidoras inclui conhecimentos em gestão pública, direito constitucional (ESG)¹¹, mediação de conflitos?
- Existem estruturas de suporte à saúde física e mental das pessoas que atuam na ouvidoria? Quem escuta aqueles que, no dia a dia, praticam a escuta ativa?
- Há suporte tecnológico às pessoas que trabalham nas ouvidorias, do ponto de vista estrutural e de capacitação para adequação às novas tecnologias?
- Quais são as demandas relacionadas à integridade, correição e gestão de riscos institucionais e que podem estar suscetíveis a práticas inadequadas, ou que necessitam de maior atenção em termos de governança?

¹⁰ Conforme Brasil (2021), essas são apenas algumas das perguntas previstas no documento de apoio para a realização da autoavaliação e do plano de ação do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP). O MMOuP foi desenvolvido para apoiar o processo de melhoria continuada na gestão das unidades de ouvidoria pública, mediante esforço da Controladoria-Geral da União, com consultoria do Programa da União Europeia para Coesão Social na América Latina (EUROSociAL).

¹¹ Environmental, Social and Governance. Para mais informações sobre o assunto, ver Brasil (2023c).

A seguir, são informadas as iniciativas em desenvolvimento pelo Ministério da Saúde:

A Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (OuvSUS) tem como um de seus principais objetivos garantir e ampliar o acesso do(a) cidadão(ã) na busca efetiva de seus direitos, atuando como ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do SUS e do controle social. Com esse intuito, apoia a implementação de ouvidorias em todo o território nacional (26 estados + DF).

Esse apoio se dá por meio de ações diretas com os gestores dos estados e municípios ou em parceria com órgãos públicos:

- Iniciativas de capacitação e formação de profissionais em ouvidorias do SUS realizadas em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) e a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública – RedEscola/ENSP/Fiocruz, por meio do projeto Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover a qualificação dos trabalhadores das ouvidorias do SUS e o exercício da sua prática, com a ampliação e consolidação da Rede de Ouvidorias do SUS. Dentre as ações realizadas nesse projeto temos:
- Oficinas remotas – oficinas virtuais realizadas por estado, dentro do escopo do Programa Qualificação de Profissionais e Trabalhadores de nível médio e superior, como ouvidores, técnicos em ouvidoria e gestores de saúde, inclusive daqueles municípios que pretendem criar sua ouvidoria. Foram capacitados profissionais de mais de 900 ouvidorias em 26 estados e no DF. Essa iniciativa faz parte de um processo de educação permanente que objetiva contribuir para

a consolidação e o fortalecimento da Rede de Ouvidorias do SUS (2022/2023).

- A Comunidade Virtual de Práticas – Ouvidorias do SUS: fortalecendo a atuação em Rede! Trata-se de uma ação educativa no formato *web* que possibilita o aprofundamento teórico sobre os múltiplos contextos nos quais se inserem as ouvidorias, bem como espaço para compartilhar experiências com diversos estados (2022/2023).
- Conferência Livre Nacional de Ouvidorias do SUS (CLNO) – com o tema “Escutatória” – pode falar, queremos ouvir vocês!” teve o objetivo de discutir o papel das ouvidorias na defesa do direito à saúde, à vida e no fortalecimento da democracia e uma grande oportunidade para contribuímos na formulação de propostas referentes à 17ª Conferência Nacional de Saúde.
- Workshop – Qualidade e Monitoramento, sobre qualidade das respostas, monitoramento e acompanhamento das manifestações das ouvidorias do SUS (setembro de 2022); Gestão e Legislação para Ouvidorias, sobre regulamentação das ouvidorias e o impacto da LGPD (2022).
- Portaria GM/MS n. 1.975, de 29 de junho de 2018 – que estabelece incentivo financeiro destinado aos Estados e ao Distrito Federal para a qualificação da gestão no Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS – ParticipaSUS, com foco na implantação, descentralização e qualificação das ouvidorias do SUS.
- Consulta Pública – Instituição da Rede de Ouvidorias do SUS – realizada por meio de formulário para receber sugestões da sociedade sobre a

competência, composição e demais aspectos relacionados à proposta de Instituição da Rede de Ouvidorias do Sistema Único de Saúde, com a finalidade de articular as atividades de ouvidoria desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, estadual e municipal.

- 1ª Workshop Nacional de Ouvidorias do SUS em Rondônia – setembro/2023 – Cenário atual da Ouvidoria-Geral do SUS: ações estruturantes em desenvolvimento, principais avanços e desafios.¹²

Uma ação recente e alvissareira em relação à proteção das mulheres e ao compartilhamento de informações no âmbito da saúde foi o lançamento, pelo Ministério da Saúde, de um aplicativo para trabalhadoras do SUS, uma ação que integra o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, iniciativa inédita do Governo Federal.

A ferramenta pretende auxiliar o enfrentamento a situações de violência, preconceito e discriminação no âmbito do SUS, mas também apresenta outras funcionalidades. O aplicativo também permitirá a socialização de experiências produzidas por movimentos sociais, universidades e secretarias de saúde, no âmbito do programa, e o fortalecimento da rede colaborativa do SUS (Brasil, 2023b).

Na esfera legislativa, a Câmara dos Deputados tem uma lista de projetos de lei que consideram proposições para as ouvidorias

¹² Informações concedidas a este estudo por e-mail em 10 de outubro de 2023, por meio da Coordenação de Atendimento ao Cidadão – COACI/Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (OuvSUS).

no país e que demandam atenção importante da área. Como exemplo, o Projeto de Lei n. 10.844/18, que obriga a criação de ouvidoria em órgãos públicos municipais, estaduais e federais. De acordo com Miranda (2019), a regra dessa proposta vale para órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluídos os tribunais de contas e o Ministério Público. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista também deverão se adequar. E, além dos órgãos públicos, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, seja diretamente do orçamento ou de convênios, acordos e similares também deverão ter ouvidorias. De acordo com o texto, as ouvidorias deverão ter infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para atender a população de acordo com as diretrizes do Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos (Lei n. 13.460/17), como cumprimento de prazos e normas. Quatro outros projetos estão apensados à proposta.



8. Recomendações

*Uma parte de sonho estará sempre nos projetos,
um grão de utopia nos objetivos. Não abriremos
mão de preservar, junto ao dever de trabalhar,
o direito de sonhar.*

Samira Nahid de Mesquita ([20--]).

Para assegurar o efetivo funcionamento das ouvidorias do SUS, é imperativo que haja um suporte abrangente em duas esferas fundamentais. Primeiro, no âmbito governamental, especificamente no Poder Executivo, é essencial implementar ações concretas que assegurem a plenitude operacional das ouvidorias. Isso envolve a alocação adequada de recursos, incluindo pessoal qualificado, equipamentos tecnológicos e ambiente humanizado.

Um número justo de servidores públicos, que conheçam o instituto da ouvidoria e a própria instituição, alocados no setor, é determinante para garantir respostas eficientes e rápidas, bem como a própria saúde do local de trabalho. Muitas vezes, a ouvidora, ou o ouvidor, como única responsável pela área, em sua própria figura como pessoa, também se confunde com a ouvidoria em si. Aquela pessoa “é” a ouvidoria. E a administração pública não precisa de heróis ou heroínas.

Quintanilha (2022) aponta que um levantamento da International Stress Management Association (Isma) mostra que o Brasil é o segundo país com mais casos de *burnout* no mundo. A síndrome foi reconhecida como doença ocupacional

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, sendo considerada um distúrbio emocional provocado pelo esgotamento físico e mental, consequência de “situações desgastantes, altamente estressantes, geradas no ambiente profissional ou pelas más condições em que o trabalho é exercido” (Quintanilha, 2022).

Portanto, além da capacitação técnica, é fundamental proporcionar suporte à saúde física e psíquica dos servidores. Dada a natureza das interações nas ouvidorias, especialmente aquelas vinculadas aos serviços de saúde, os funcionários podem enfrentar situações estressantes em modo contínuo. Assim, medidas que visem o bem-estar emocional, como apoio psicológico e programas de saúde mental, são indispensáveis para garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

O investimento em infraestrutura tecnológica, medida básica, é vital para otimizar os processos de atendimento e garantir a segurança das informações. A modernização dos sistemas também contribui para a agilidade na análise e resolução das demandas apresentadas pelos cidadãos e pelas cidades.

Em segundo lugar, na esfera gerencial do cotidiano das ouvidorias de saúde, é imperativo que os servidores públicos que atuam nessas instâncias recebam formação continuada de acordo com os princípios da Política de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) (Brasil, 2018).

A PNEPS (Brasil, [200-]) representa uma importante estratégia do SUS e tem objetivo de contribuir para a organização dos serviços de saúde, com a qualificação e a transformação das práticas em saúde. Por meio da formação e do desenvolvimento dos profissionais e trabalhadores da saúde, pretende

articular a integração entre ensino e serviço, com vistas ao fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS. O apoio por meio da facilitação do acesso a programas de especialização e cursos frequentes é a estratégia para manter esses profissionais atualizados em relação às práticas mais recentes e às demandas específicas de suas áreas de atuação.

Considerando a necessidade de retomar o financiamento e o processo de planejamento das ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) no nível estadual e local, a Gestão Federal lançou o PRO EPS-SUS [Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS], via Portaria GM/MS n. 3.194, de 28 de novembro de 2017, com o objetivo de estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores da área da saúde, para a transformação das práticas de saúde, em direção ao atendimento dos princípios fundamentais do SUS, a partir da realidade local e da análise coletiva dos processos de trabalho. Tal iniciativa se caracteriza pelo repasse financeiro do MS diretamente aos municípios para que realizem ações de EPS nos territórios (Brasil, 2018, p 23).

Entre os objetivos do PRO EPS-SUS destaca-se “a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos, referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde” (Brasil, 2018, p. 25).

É importante destacar ainda, em diálogo com a PNEPS, as orientações previstas, também no âmbito do SUS, com relação à participação popular no sistema, segundo a Portaria n. 2.761, de 19 de novembro de 2013, que institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). Em destaque, alguns de seus artigos:

Art. 2º A PNEPS-SUS reafirma o compromisso com a universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS, e propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS.

Art. 3º A PNEPS-SUS é orientada pelos seguintes princípios:

- I - diálogo;
- II - amorosidade;
- III - problematização;
- IV - construção compartilhada do conhecimento;
- V - emancipação; e
- VI - compromisso com a construção do projeto democrático e popular.

Art. 5º A PNEPS-SUS tem como objetivo geral implementar a Educação Popular em Saúde no âmbito do SUS, contribuindo com a participação popular, com a gestão participativa, com o controle social, o cuidado, a formação e as práticas educativas em saúde (Brasil, 2013).

É notório que a PNEPS-SUS reconhece e valoriza o cotidiano como lugar de invenções, acolhimento de desafios e substituição criativa de modelos por práticas cooperativas, colaborativas, consensuais, integradas e corajosas na arte de escutar a diversidade e a pluralidade do país. E essa troca tem o condão de, pedagogicamente, encontrar a unidade na pluralidade, da teoria à prática, um compromisso bastante enriquecedor e dialógico, que também reforça o papel multidisciplinar e transdisciplinar da ouvidoria no SUS. O texto da PNEPS-SUS se traduz num avanço emancipatório.



Fonte: Foto de Fernando Frazão (Agência Brasil).

Experiências de excelência em formações voltadas para ouvidorias fazem parte da história recente do SUS. Com metodologias já experimentadas e bem-sucedidas, são exemplos para serem incorporados ao processo de retomada das políticas públicas de valorização do SUS, do estímulo à democracia participativa e, também, do fortalecimento das ouvidorias em saúde.

Em 2014, foi realizado o 1º Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS como resultado de uma parceria estabelecida em 2011 entre a Vice-Direção da Escola de Governo em Saúde (VDEGS/ENSP/Fiocruz), o Departamento Geral de Ouvidoria do SUS (Doges), o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS) da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde (SGEP/MS) e a Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública.

A articulação gerou um curso de mestrado profissional voltado para profissionais do Doges/SGEP/MS lotados em Brasília (DF); um curso de qualificação direcionado a profissionais de auditoria e ouvidoria nas 27 unidades da federação; e na proposta de cursos de ensino a distância (Feijão *et al.*, 2014).

A autora do presente relatório foi uma das ministrantes do curso e reforça, aqui, a importância da adoção da mediação de conflitos, um mecanismo de autocomposição de litígios, adotado em muitas das ouvidorias públicas espalhadas pelo Brasil e um dos temas do curso:

Mediação de conflitos: busca de solução pacífica para os problemas de ordem jurídica, com uma abordagem humanizada do conflito, que visa a harmonia entre as partes, a construção de consensos, a partir da prática da compaixão e da alteridade, com base em prática inovadora que valoriza e viabiliza o diálogo e a comunicação. A mediação de conflitos é um mecanismo de acesso à justiça, já que dá ênfase à transparência do serviço e à participação do cidadão e, consequentemente, pode contribuir para mitigar a judicialização da saúde (Feijão *et al.*, 2014, p. 61).

Souza, Costa e Muñoz (2022) apontam os resultados do processo de formação de ouvidores do Sistema Único de Saúde (SUS), em duas turmas nos anos de 2015 e 2016. Esse processo foi fruto de uma parceria entre a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), a Rede Brasileira de Escola de Saúde Pública (RedEscola) e a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do SUS (SGEP/MS). Considerada pioneira, a formação foi desenvolvida dentro da lógica de construção participativa e mobilizou agentes municipais, estaduais e nacionais das ouvidorias do SUS, instituições/escolas de saúde pública estaduais, Conselho Nacional de Secretarias

Municipais de Saúde (Conasems) e Secretaria Técnica e Executiva da RedEscola, resultando na formação de 451 ouvidores e ouvidoras.

O curso também impulsionou a ampliação da produção acadêmica sobre a Ouvidoria do SUS, relativamente escassa até então, assim como a redefinição do papel das Ouvidorias do SUS como instrumento de gestão, contribuindo para a construção de soluções. A publicação sobre a UA2, por exemplo, foi o primeiro material didático elaborado exclusivamente para a Ouvidoria do SUS.

A estrutura de governança complexa e participativa também representou, sobretudo aos gestores estaduais e municipais, o caráter pedagógico da Ouvidoria como um instrumento aliado da gestão, fortalecendo a inserção dela de forma institucional, como prática cotidiana da gestão, mantendo a construção contínua de saberes dessas áreas e sua continuidade (Souza; Costa; Muñoz, 2022, p. 162).¹³

Os desafios de comunicação entre profissionais de diferentes formações em um mesmo espaço é objeto de estudo de Barbosa *et al.* (2021), que realizaram uma revisão integrativa da literatura de abordagem qualitativa sobre o tema. A pesquisa foi centrada na aplicabilidade da educação interprofissional no âmbito da atenção primária em saúde.

Nesse contexto, existe uma crescente incorporação da Educação Interprofissional (EIP), como um processo formativo e de trabalho em saúde em todo o mundo, com a crença de que a implementação de seus princípios poderia melhorar a satisfação no trabalho, melhorar a resolutividade das demandas e aumentar a apreciação da comunidade sobre a equipe de saúde.

¹³ O curso produziu material didático composto por duas Unidades de Aprendizagem (UA): a UA1 – Estado, Saúde e Sociedade; e a UA2, com temas referentes à ouvidoria do SUS.

Dessa forma, com a perspectiva da EIP, todos os profissionais de saúde deveriam participar ativamente em sistemas de saúde centrados assim na população e no usuário respeitando as diversas práticas de acordo com cada profissão, com análise crítica, ética e ênfase em práticas colaborativas (Rossit, Freitas, Batista e Batista, 2018). (Barbosa *et al.*, 2021, p. 3).

A comunicação é um objeto precioso para o trabalho em ouvidoria e a comunicação interprofissional requer uma conversação solidária, que fomente e reflita as transformações no agir, visando a promoção da humanização, da criação e da libertação dos processos de trabalho permutantes.

Os resultados do estudo realizado por Barbosa *et al.* (2021) apontam que ainda existem empecilhos para a absorção das práticas interprofissionais, devido a recusas na adoção de práticas colaborativas, já que faltam qualificação e capacitação sobre essas práticas nos locais de trabalho. Assim, os autores defendem a ampliação do acesso de trabalhadores da área da saúde a ações que estimulem a interprofissionalidade, principalmente aqueles alocados na Atenção Básica. A nosso ver, essa recomendação também é muito bem-vinda para aplicação em todas as ações e serviços da gestão e trabalho na área de saúde.

Do ponto de vista da macrogestão e da elaboração de políticas públicas e ações sob a responsabilidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, espera-se que os planejamentos estratégicos para os próximos anos incluam o tema da integridade institucional de forma categórica. Além do referencial constitucional das ações, é imperioso que todas as propostas em curso estejam alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU¹⁴. Esses planejamentos podem contemplar:

¹⁴ Cf. Organização das Nações Unidas (2023).

- **Inclusão da integridade institucional no Plano Estratégico Anual:** inserir o tema da integridade pública nos planos estratégicos anuais de gestores públicos, legisladores e setores do judiciário como uma prioridade. Reconhecer sua importância para o fortalecimento institucional com a possibilidade de criação de comitês permanentes de gestão de riscos, além do aprimoramento dos processos de correição desempenhados por diferentes setores, a depender da instituição. Considerar o desenvolvimento da área de integridade institucional na previsão orçamentária.
- **Adotar o tema da integridade nas políticas de comunicação social:** incluir o tema no planejamento de relações públicas e relacionamento com a imprensa; produzir campanhas de endomarketing e de comunicação com o público externo.
- **Realização de seminários públicos:** organizar seminários públicos com ampla participação popular para disseminar informações sobre integridade pública, promover o engajamento cívico e conscientização da sociedade sobre a importância da ética na gestão pública.
- **Estímulo à formação de servidores:** implementar programas de formação e capacitação para os servidores, abrangendo a compreensão e a aplicação de princípios de integridade e ESG.
- **Produção de webinars e lives gratuitos:** incentivar a discussão sobre o tema da integridade institucional por meio de *webinars* e *lives*, utilizando plataformas digitais e as redes sociais para alcançar um público mais amplo e facilitar a interação em tempo real.

- **Realização de encontros presenciais regionais e nacionais:** fomentar encontros presenciais regionais e nacionais para promover o diálogo e a troca de experiências entre diferentes esferas do poder público e ouvidorias do SUS, reforçando a importância da integridade em todas as instâncias governamentais.
- **Realização e participação em eventos internacionais:** realizar eventos internacionais para discutir o tema da integridade pública, convidando especialistas com notório saber nessas áreas para compartilhar experiências e boas práticas em nível global. E, ainda, apoiar a participação de gestores em eventos internacionais sobre o tema, com a possibilidade de divulgação dos resultados da sua organização.
- **Produção de materiais educativos:** elaborar cartilhas, manuais, e-books e outros materiais educativos sobre integridade pública, distribuindo-os amplamente e disponibilizando em sites institucionais para informar e sensibilizar a população.
- **Elaboração de projetos de lei:** propor e elaborar projetos de lei que fortaleçam o arcabouço jurídico relacionado à integridade pública no âmbito das ouvidorias do SUS, garantindo uma base legal sólida para práticas éticas na administração pública.
- **Ações internas de diálogo:** implementar ações internas para promover o diálogo sobre integridade entre gestores e ouvidores, criando um ambiente propício à discussão aberta sobre ética e conduta no serviço público. A inclusão da ouvidoria em algumas das reuniões estratégicas da alta gestão, por exemplo, é uma medida que fomenta a confiança interna e melhora os fluxos de comunicação.

- **Fomento à pesquisa em parceria com instituições de ensino superior:** incentivar a pesquisa em parceria com laboratórios de pesquisa de instituições de ensino superior, buscando avanço no conhecimento sobre práticas eficazes de integridade, bem como a promoção de abordagens críticas e o desenvolvimento de metodologias de formação.
- **Premiações:** lançar premiações para valorizar e disseminar boas práticas e experiências desenvolvidas nas ouvidorias e que podem servir de referencial para o trabalho na área.

No âmbito do Ministério da Saúde, é altamente recomendável a realização de uma pesquisa de caráter nacional, com aplicação em todas as ouvidorias, de forma a conhecê-las em termos de infraestrutura, mas também com a aplicação de um questionário que se aprofunde de forma qualificada nas questões de visibilidade institucional, conhecimento e aplicação dos conceitos de integridade no cotidiano de cada equipe e de cada organização.

Do ponto de vista da microgestão, do planejamento da própria ouvidoria, diversos são os procedimentos, metodologias, programas, formatos institucionais e de fluxograma, ações e concepções referenciadas, antes de tudo, na valorização dos princípios democráticos e das boas práticas de gestão, capazes de criar um ambiente voltado para o fomento da integridade institucional. Algumas recomendações:

- **Fluxos de atendimento da ouvidoria:** a ouvidoria deve estabelecer e apresentar de forma clara os fluxos de atendimento, desde a recepção das demandas até a prestação de contas aos usuários, com linguagem simples, desburocratizada, sem o uso de siglas alheias à realidade dos usuários e adequadas às normas de acessibilidade.
- **Planejamento anual da ouvidoria em sintonia com o planejamento da alta gestão:** é importante integrar o planejamento anual da ouvidoria com as metas e os objetivos estabelecidos pela alta gestão do órgão de saúde, tendo como fim o atendimento da missão institucional de cada órgão.
- **Desenvolvimento de políticas de comunicação:** formular comunicações voltadas para o benefício das comunidades interna e externa, relevantes dentro do cenário crítico de disseminação de *fake news* e de desinformação. Utilizar canais diversos, como mídias sociais e ferramentas tradicionais de comunicação interna, como urnas para depósito de sugestões, cartazes, reuniões de escuta ativa nas comunidades.
- **Criação de manual de conduta ética e contra discriminações, adoção de protocolo de convivência:** pode estar no âmbito da ouvidoria a responsabilidade de publicação de um manual de conduta ética, de um protocolo de convivência, estabelecendo diretrizes claras para a atuação dos membros da instituição.
- **Desenvolvimento de habilidades emocionais exigidas pelo século 21:** implementar programas de treinamento que visem o desenvolvimento de habilidades emocionais, como empatia e comunicação não violenta¹⁵.

¹⁵ Para uma discussão mais aprofundada sobre o tema, ver Riche (2023).

Cada região, cada município do Brasil tem suas características que os tornam singulares; o fazer das ouvidorias também envolve o desenvolvimento sensível de soluções que apenas os profissionais que estão lá, no dia a dia do contato com o público, têm capacidade de enxergar, identificar, entender.

As diretrizes aqui mencionadas são apenas uma fração do universo de práticas e saberes disponíveis para que as ouvidorias do SUS possam fortalecer sua contribuição para a promoção de uma cultura de integridade e, ao mesmo tempo, de uma cultura de paz e emancipatória nos locais em que atuam.





9. Implicações práticas e teóricas

Adotar uma ética do amor significa que utilizamos todas as dimensões do amor – ‘cuidado, compromisso, confiança, responsabilidade, respeito e conhecimento’ – em nossa vida cotidiana. Só podemos fazer isso com sucesso cultivando a consciência.

Bell Hooks (2000, p. 94, tradução nossa).

O advento da integridade pública como tema central nas políticas governamentais é recente e, como qualquer novidade, gera dúvidas e abre caminhos para o seu melhor conhecimento. Trata-se de um tema caro para a sociedade brasileira que, historicamente, viu no servidor público a figura de pouca eficiência. Mais que uma gestão da reputação ou da imagem dos servidores, essa mudança de percepção demanda ações sérias e comprometidas com a população. Outro tema relevante para a população é a questão da corrupção, apontada em qualquer pesquisa de opinião como um dos graves problemas que assolam o país.

Assim, estimular a integridade pública como cultura é uma oportunidade para a administração governamental passar a, cotidianamente, estimular as melhores práticas de gestão, divulgar o que faz de melhor, ampliar o diálogo institucional e com a sociedade, ampliar a confiança e compartilhar a sua experiência com o público. As ouvidorias do SUS precisam de apoio dos seus gestores e de políticas públicas efetivas que

reforcem o compromisso com a participação e a integridade institucional. No âmbito da gestão pública, os primeiros referenciais teóricos surgem na esfera da correição, notadamente ligada ao âmbito da Controladoria-Geral da União e, também, ao Tribunal de Contas da União, mas a abordagem específica para a saúde precisa passar a existir e subsidiar as ações dos profissionais de ouvidoria.





10. Considerações finais

Democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. Essa talvez seja uma das originalidades da democracia. Porque procura instituir esses direitos como tais, leis, exige que sejam reconhecidos e respeitados. A democracia está aberta ao tempo, ao novo, ela é criação do novo.

Marilena Chauí (Duarte, 2019).

A adoção de práticas de integridade e, mais ainda, a sistematização e o controle sobre sua adoção, são benéficas para a sociedade. No âmbito da administração pública, cabe aos servidores e servidoras, aos gestores e governantes, implementar com a maior celeridade a cultura da integridade. O arcabouço jurídico para a adoção da integridade precede até mesmo o Decreto n. 11.529, de 22 de novembro de 2017, visto que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um dos instrumentos jurídicos mais completos e exemplares para as democracias ao redor do mundo.

O referido decreto, considerado um marco para a integridade na administração pública, realiza uma operação matemática de soma qualificada a uma série de outros dispositivos jurídicos à disposição da sociedade. No âmbito das ouvidorias do SUS, a aplicação da lei exige agilidade para seu cumprimento e conhecimento qualificado para que isso se dê de forma correta. Daí, a necessidade de formação de gestores, de profissionais de ouvidoria e da produção de informação voltada à área da saúde.

A Constituição é a ata do pacto social, segundo ensinou Frei Caneca¹⁶. A retirada da população da participação dos conselhos democráticos, na história recentíssima do país, tem implicações diretas e negativas sobre o trabalho em ouvidorias, afetando significativamente a transparência pública. Os conselhos desempenham um papel orgânico na democracia, ao proporcionar um espaço para que a sociedade civil discuta políticas públicas e influencie a tomada de decisões. E a retomada precisa de muita pujança.

Da mesma forma, a descontinuidade de ações e, frise-se, de provimento orçamentário para ações no âmbito da saúde pública compromete não apenas a integridade das instituições, mas também a das pessoas que nelas trabalham.

Contudo, o cenário é promissor. As ouvidorias – instrumentos, por essência, da humanização dos serviços públicos e de estímulo e prática da democracia participativa – encontram hoje um cenário favorável à cooperação de forma sistematizada e planejada, comprometida com a promoção da integridade pública no país e no âmbito do SUS nas esferas federal, estadual e municipal.

¹⁶ Para aprofundamento do tema, ver Bernardes (1997).





11. Referências

ANTUNES, André. *Entra atenção primária, sai o controle social*. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 24 maio 2019. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/entra-atencao-primaria-sai-o-controle-social>. Acesso em: 20 nov. 2023.

BAHIA. Corregedoria-Geral da Justiça. *Correições judiciais*. Salvador: Corregedoria PJBA, 2023. Disponível em: <http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/correicoes-judiciais/>. Acesso em: 19 nov. 2023.

BARBOSA, Maria Leticia Cardoso da Silva *et al.* Os desafios na aplicabilidade da educação interprofissional no âmbito da atenção primária em saúde. *Research, Society and Development*, [s. l.], v. 10, n. 15, e348101522942, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22942>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/356622308_Os_desafios_na_aplicabilidade_da_educacao_interprofissional_no_ambito_da_atencao_primaria_em_saude. Acesso em: 30 out. 2023.

BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. Pacto social e constitucionalismo em Frei Caneca. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 11, n. 29, p. 155-168, 1 abr. 1997. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8977>. Acesso em: 25 nov. 2023.

BERNARDES, José Eduardo. *Elite intelectual é burra e não percebe a riqueza da pluralidade, diz Conceição Evaristo*. [São Paulo], 9 ago. 2021. Podcast. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/elite-intelectual-e-burra-e-nao-percebe-a-riqueza-da-pluralidade-diz-conceicao-evaristo>. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2023a]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 jan. 2024.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Correição*. Brasília, DF: Corregedorias, 27 abr. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/corregedorias/pt-br/assuntos/perguntas-frequentes/correicao>. Acesso em: 20 jul. 2023.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Integridade pública*. Brasília, DF: Controladoria-Geral da União, [2019?]. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica/integridade-publica>. Acesso em: 20 set. 2023.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Saiba mais*. Brasília, DF: Controladoria-Geral da União, [2023?]. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica/integridade-publica/saiba-mais>. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Ministério da Saúde lança aplicativo para trabalhadoras do SUS*. Brasília, DF: Agência.Gov, 10 de out. 2023b. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202310/ministerio-da-saude-lanca-aplicativo-para-apoiar-trabalhadoras-do-sus-no-enfrentamento-a-situacoes-de-violencia-e-discriminacao>. Acesso em: 20 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Portaria n. 2.761, de 19 de novembro de 2013*. Institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html. Acesso em: 1 dez. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. *Política Nacional de Educação Permanente em Saúde*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [202-]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/pneps>. Acesso em: 2 dez. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. *Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS: ParticipaSUS*. 2. ed. Brasília, DF: Editora do Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_estrategica_participasus_2ed.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde; CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (Brasil); CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (Brasil). *Prêmio Cecília Donnangelo de Ouvidoria SUS*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio_cecilia_donnangelo_ouvidoria_sus.pdf. Acesso em: 1 jan. 2024.

BRASIL. Ministério Público da União. Auditoria Interna. *Cartilha ESG e a gestão pública: uma visão geral*. Brasília, DF: Audin, 2023c. Disponível em: <https://auditoria.mpu.mp.br/documentos-audin-mpu/manuais-e-cartilhas/cartilha-da-audin-mpu/cartilha-esg-e-a-gestao-publica-uma-visao-geral/cartilha-esg-assinada.pdf>. Acesso em: 28 out. 2023.

BRASIL. Ouvidorias. *Modelo de maturidade em ouvidoria pública*. Brasília, DF: Ouvidorias.Gov, 23 fev. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/modelo-de-maturidade-em-ouvidoria-publica>. Acesso em: 18 nov. 2023.

CALDEIRA, Marcos; DUFLOTH, Simone Cristina. A lei das estatais e as diretrizes internacionais: convergências para o estado da arte em integridade, *compliance* e anticorrupção. *Cadernos EBAPE.BR*, São Paulo, v. 19, p. 675-688, 2021. Disponível em <https://www.redalyc.org/journal/3232/323269840005/html/>. Acesso em: 19 nov. 2023.

CAOVILLA; Maria Aparecida Lucca; BOITA; Manoel; BALBINOTTI, Carmelice. Educação jurídica para o bem viver: a superação de um arquétipo eurocêntrico para uma epistemologia do Sul. *Revista Interinstitucional Artes de Educar*, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 566-580, out. 2018/jan. 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/riae/article/view/39592/28476>. Acesso em: 10 ago. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). *Brasil se torna referência mundial sobre Participação Social em Saúde*. [Brasília, DF]: Conselho Nacional de Saúde, 29 maio 2024. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/3434-brasil-se-torna-referencia-mundial-sobre-participacao-social-em-saude>. Acesso em: 29 maio 2024.

COVID, ano três: 700 mil mortos. *Focus Brasil*, São Paulo, 2 abr. 2023. Disponível em: <https://fpabramo.org.br/focusbrasil/2023/04/02/covid-ano-tres-700-mil-mortos/>. Acesso em: 10 ago. 2023.

DALLARI, Dalmo de Abreu. *O que são direitos da pessoa*. São Paulo: Brasiliense, 1982.

DALCOMO, Margareth. Vacina é a única solução. [Entrevistada por] Ana Cláudia Peres e Luiz Felipe Stevanim. *Radis*, Rio de Janeiro, 14 abr. 2023. Disponível em: <https://radis.ensp.fiocruz.br/entrevista/vacina-e-a-unica-solucao/>. Acesso em: 29 mar. 2024.

DUARTE, Rafael. *Marilena Chaui*: Democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. Natal: Saiba Mais Agência de Reportagem, 16 out. 2019. Disponível em: <https://saibamais.jor.br/2019/10/marilena-chaui-democracia-e-a-unica-sociedade-e-o-unico-regime-politico-que-considera-o-conflito-legitimo/>. Acesso em: 20 fev. 2024.

EDELMAN TRUST INSTITUTE. *Edelman Trust Barometer 2023: relatório especial: confiança e saúde no Brasil*. [S. l.]: Edelman Trust Institute, 2023b. Disponível em: https://www.edelman.com.br/sites/g/files/aatuss291/files/2023-08/POR_2023%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Special%20Report%20Trust%20and%20Health%20Brazil%20Report%20%282%29.pdf. Acesso em: 26 out. 2023.

EDELMAN TRUST INSTITUTE. *Edelman Trust Barometer 2023: relatório nacional*. [S. l.]: Edelman Trust Institute, 2023a. Disponível em: https://www.edelman.com.br/sites/g/files/aatuss291/files/2023-04/2023%20Edelman%20Trust%20Barometer_Brazil%20Report_POR%20%281%29_0.pdf. Acesso em: 27 ago. 2023.

FEIJÃO, A. M. M. et al. (org.). *Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS*. 1. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz/ESNP, 2014. Disponível em: https://redescola.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/curso_nacional_de_qualificacao_de_auditorias_e_ouvidorias_do_sus_-_ouvidoria.pdf. Acesso em: 11 nov. 2023.

HADDAD, Naief. Mandela soube perdoar, diz Graça Machel durante palestra em São Paulo. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 16 maio 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/05/mandela-soube-perdoar-diz-graca-machel-em-sp.shtml>. Acesso em: 20 fev. 2024.

HOOKS, Bell. *All about love*. New York: Harper Perennial, 2000.

JEAN-PHILIPPE, McKenzie. *9 essential Angela Davis books to add to your shelf*. [S. l.], 8 jun. 2020. Disponível em: <https://www.oprahdaily.com/entertainment/books/g32803115/angela-davis-books/>. Acesso em: 20 fev. 2024.

JORNAL NACIONAL. Pesquisa mostra que 75% dos conselhos e comitês nacionais foram extintos ou esvaziados no governo Bolsonaro. *G1*, [s. l.], 25 out. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/10/25/pesquisa-mostra-que-75percent-dos-conselhos-e-comites-nacionais-foram-extintos-ou-esvaziados-no-governo-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 15 nov. 2023.

LISBOA, Vinícius. *Fake news sobre vacinas buscam gerar medo, dúvidas e lucro*. Brasília, DF: Agência Brasil, 17 set. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-09/fake-news-sobre-vacinas-buscam-gerar-medo-duvidas-e-lucro>. Acesso em: 10 out. 2023.

LYRA, R. P. Ouvidor: o defensor dos direitos na administração pública brasileira. In: LYRA, R. P. *Autônomas x obedientes: a ouvidoria pública em debate*. João Pessoa: Ed. UFPB, 2004. p. 119-152. Disponível em: <https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Ouvidorias.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2023.

MALTCHIK, Roberto. O que falta para que as ouvidorias impactem os serviços públicos? *Jota*, Rio de Janeiro, 16 out. 2023. Disponível em: <https://www.jota.info/executivo/o-que-falta-para-que-as-ouvidorias-impactem-os-servicos-publicos-16102023>. Acesso em: 2 nov. 2023.

MESQUITA, Samira Nahid de. [Placa]. [Rio de Janeiro]: Centro de Letras e Artes da UFRJ, [20--]. Placa.

MIRANDA, Tiago. *Ouvidoria poderá ser obrigatória em órgãos públicos e entidade privada com recurso público*. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 24 jan. 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/550949-ouvidoria-podera-ser-obrigatoria-em-orgaos-publicos-e-entidade-privada-com-recurso-publico/>. Acesso em: 10 jul. 2023.

OLIVEIRA, Marina de Carvalho. *Pela emoção, pela imaginação: Nise da Silveira e a poética do cuidado*. São João Del-Rei: PPGPSI-UFESJ, 2020. Disponível em: <https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ppgpsi/Dissertacao%20Final%20Marina%20Oliveira.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Como as Nações Unidas apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil*. Brasília, DF: ONU, c2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 10 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. [S. l.: s. n.], 1948. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/por.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2020 75/186: el papel de las instituciones de ómbudsman y mediadores en la promoción y protección de los derechos humanos, la buena gobernanza y el estado de derecho*. [S. l.]: ONU, 20 dez. 2020. Disponível em: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/373/14/PDF/N2037314.pdf?OpenElement>. Acesso em: 8 fev. 2021.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Entenda a infodemia e a desinformação na luta contra a COVID-19: kit de ferramentas de transformação digital: ferramentas de conhecimento*. [S. l.]: OPAS, 2020. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52054/Factsheet-Infodemic_por.pdf. Acesso em: 10 nov. 2023.

PARANÁ. Defensoria Pública. *Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas*. Curitiba: DPE PR, [20--]. Disponível em: <https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Conselho-Nacional-de-Ouvidorias-de-Defensorias-Publicas>. Acesso em: 15 ago. 2023.

QUINTANILHA, Daniela. Brasil é o segundo país com mais casos de burnout, diz levantamento. *IstoÉ Dinheiro*, [s. l.], 7 set. 2022. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-casos-de-burnout-diz-levantamento/>. Acesso em: 23 out. 2023.

RICHE, Cristina Ayoub. *Memórias da Ouvidoria: aprendizados de 2009 a 2021*. Rio de Janeiro: Ouvidoria-Geral da UFRJ, 2021.

RICHE, Cristina Ayoub. Ouvidoria pública: direito de quarta geração, caminho para o diálogo. *Defensores Universitários*, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 19-30, jul./dic. 2011.

RICHE, Cristina Ayoub. O papel das ouvidorias no contexto da crise democrática. *Revista Científica da Associação Brasileira de Ouidores/Ombudsman*, São Paulo, ano 7, n. 6, p. 27-37, 2023. Disponível em: https://revista.abonacional.org.br/files/edicoes/artigos/revista_abo_2023_web.pdf. Acesso em: 1 dez. 2023.

SARLET, Ingo Wolfgang; MOLINARO, Carlos Alberto. Direito à informação e direito de acesso à informação como direitos fundamentais na Constituição Brasileira. *Revista da AGU*, Brasília, DF, ano 13, n. 42, p. 9-38, out./dez. 2014. Disponível em: https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11403/2/Direito_a_768_Informac_807_a_771_o_e_Direito_de_Acesso_a_768_Informac_807_a_771_o_como_Direitos_Fundamentais_na.pdf. Acesso em: 10 nov. 2023.

SCHIRATO, Vitor Rhein. *O controle interno da administração pública e seus mecanismos*. [S. l., 2015]. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4141308/mod_resource/content/1/Leitura%20obligat%C3%B3ria.pdf. Acesso em: 19 nov. 2023.

SOUZA, Herbert de. *Ética e cidadania*. São Paulo: Moderna, 1994.

SOUZA, Rosa Maria Pinheiro; COSTA, Patricia Pol; MUÑOZ, Francisco Gastón Salazar. As ouvidorias do SUS e a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: uma experiência inédita. *Saúde Debate*, Rio de Janeiro, v. 46, n. 4, p. 152-165, nov. 2022. Número especial. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/DhtjHh43MK6YbPWwTG9XwkR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 out. 2023.

STRECK, Lenio. *Lenio Streck: juízos morais e 'voz das ruas' não podem valer mais que Direito e Constituição*. [Entrevistado por] Marco Weissheimer. Porto Alegre: Sul21, 5 ago. 2019. Disponível em: https://sul21.com.br/entrevistasz_areazero/2019/08/lenio-streck-juizos-morais-e-voz-das-ruas-nao-podem-valer-mais-que-direito-e-constituicao/. Acesso em: 10 nov. 2023.

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL-BRASIL. *Recomendações de transparência e governança pública para prefeituras*. São Paulo: Transparência Internacional, 2022. Disponível em: <https://transparenciainternacional.org.br/recomendacoes-para-prefeituras/>. Acesso em: 20 nov. 2023.

TRINDADE, Nísia. *Em discurso na Assembleia Mundial da Saúde, ministra Nísia Trindade fala sobre equidade e cultura de paz*. [Brasília, DF]: Ministério da Saúde, 22 maio 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/maio/em-discurso-na-assembleia-mundial-da-saude-ministra-nisia-trindade-fala-sobre-equidade-e-cultura-de-paz>. Acesso em: 20 fev. 2024.

UNICEF. *O que são direitos humanos?* Brasília, DF: UNICEF Brasil, [2019]. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/o-que-sao-direitos-humanos>. Acesso em: 10 nov. 2023.

ZILDA Arns: a humanista incansável. *In*: CONFERÊNCIAS Nacionais de Saúde: contribuições para a construção do SUS. Rio de Janeiro: Centro Cultural do Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <http://www.ccs.saude.gov.br/cns/zilda-arns.php>. Acesso em: 20 fev. 2024.

ANEXO A

Relatório do levantamento bibliográfico para o Projeto Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS

Nuno dos Santos Francisco Junior

Levantamento do referencial bibliográfico e
sistematização dos resultados da pesquisa

Cristina Ayoub Riche

Orientação

Sumário

1. Introdução.....	113
2. Metodologia.....	114
3. Resultados.....	116
Distribuição de trabalhos por repositórios científicos.....	117
Distribuição de trabalhos por categoria.....	118
Perfis da pesquisa.....	120
Panorama dos artigos compatíveis.....	121
Nuvem de palavras.....	123
4. Considerações finais.....	124
5. Referências.....	125



1. Introdução

No ano de 1988, a Constituição nascida após o período de opressão militar é promulgada tendo como ponto central a participação cidadã e a garantia dos direitos humanos para a população brasileira. Fruto da participação de diversos grupos sociais, uma das pautas incrementadas nessa nova constituição foi o acesso à saúde para todos, representado na figura do Sistema Único de Saúde (SUS), que posteriormente viria a se tornar o sistema mais amplo de saúde pública do mundo, cobrindo diversos tipos de tratamentos médicos e planos de vacinação nacional (Bertoni *et al.*, 2020).

Como forma de criar um vínculo maior do SUS com a população, em 2003 foi criada a Ouvidoria-Geral do SUS para implementar a participação social da população e fomentar a transparência no sistema. Em 2017, com a sanção da Lei de Proteção e Defesa do Usuário (Brasil, 2017), os serviços de Ouvidoria e participação social, que ainda eram escassos nos serviços públicos, passaram a ser amplamente mais incentivados. Esse fato fez com que mais serviços de saúde vinculados a rede do SUS passassem a implantar ouvidorias em seu sistema, para assim cumprir exigências internacionais sobre transparência, como o Índice de Transparência e Governança Pública, da Transparência Internacional (Transparência Internacional-Brasil, 2023) e, no âmbito nacional, cumprir as necessidades vinculadas à Controladoria-Geral da União (CGU) para o combate à corrupção (Brasil, 2023).

Tendo em tela esse cenário, o seguinte relatório tem como objetivo apresentar, de forma sucinta, os resultados obtidos no levantamento bibliográfico pertinente ao tema “Fortalecimento

da Ouvidoria-Geral do SUS” e, também, o panorama geral do levantamento.

Como forma de facilitar a compreensão sobre os resultados encontrados, nas páginas a seguir serão apresentados detalhes da metodologia utilizada para esse levantamento bibliográfico, além dos resultados obtidos em cada um dos repositórios científicos e de uma análise dos resultados gerais da pesquisa.

2. Metodologia

No levantamento de textos para essa pesquisa utilizamos operadores booleanos como descritores de busca em nove repositórios de trabalhos científicos: Google Acadêmico (383 resultados), SciELO (26 resultados), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (sem resultados), Lilacs (seis resultados), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) (55 resultados), Artigo 19 (sem resultados), Repositório da Controladoria-Geral da União (sem resultados), Transparência Brasil (quatro resultados) e Pubmed (20 resultados).

Como descritores de busca, elaboramos palavras-chave que poderiam gerar resultados mais fidedignos à seguinte proposta de pesquisa: realizar pesquisa e estudo na área de ouvidoria e participação social, aplicada aos processos de integridade institucional; na área correcional e na área de gestão de riscos institucionais aplicada ao SUS. A partir da proposta apresentada, definimos os seguintes descritores para busca nos repositórios: Ouvidoria*saúde¹⁷, *Compliance*, Governança, Integridade, Participação Social, Saúde Pública e SUS.

¹⁷ A utilização de asterisco em descritores exerce a função de caráter coringa. Neste caso, como em alguns outros, podem aparecer diferentes variações, como ouvidoria em saúde, ouvidoria de saúde ou ouvidoria na saúde. A utilização do asterisco permite que as diferentes variações desse termo sejam apresentadas na busca.

Em termos de recursos dos motores de buscas, o Google Acadêmico é o melhor repositório para pesquisa, pois possibilita combinações avançadas de descritores para resultados mais precisos. Dada essa limitação presente em outros repositórios, tivemos que usar descritores menos completos como, por exemplo, somente “Ouvidoria AND Saúde Pública” em alguns casos. No fluxograma a seguir pode-se observar o caminho que seguimos para a pesquisa.

Fluxograma 1 – Processo de pesquisa



Fonte: Elaboração do autor.

Utilizando diferentes combinações de descritores, conforme apresentado acima, obtivemos 494 resultados¹⁸ em todas as plataformas analisadas. Desses trabalhos, 397 foram excluídos com base nos seguintes critérios:

1. Não tinham relação direta com o tema da pesquisa;
2. Apesar de terem alguns descritores pertinentes à pesquisa, alguns trabalhos não apresentavam como foco as ouvidorias de saúde, saúde pública e o SUS;
3. Alguns trabalhos estavam duplicados; e
4. Alguns não eram compatíveis com o recorte temporal entre 2013 e 2023.

Outro critério utilizado para essa análise foi o de observar se os trabalhos tinham alguma relação com a Lei Anticorrupção (Brasil, 2013), a Lei de Acesso à Informação (Brasil, 2011) e a Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público (Brasil, 2017).

A seguir apresentaremos os resultados da pesquisa.

3. Resultados

Na seção de resultados, apresentaremos as principais tendências a partir da busca realizada nos repositórios acadêmicos; um panorama dos dois trabalhos que cumprem mais requisitos do tema de pesquisa e, por fim, uma nuvem de palavras contendo todas as palavras-chave presentes nos 97 trabalhos encontrados nas buscas¹⁹.

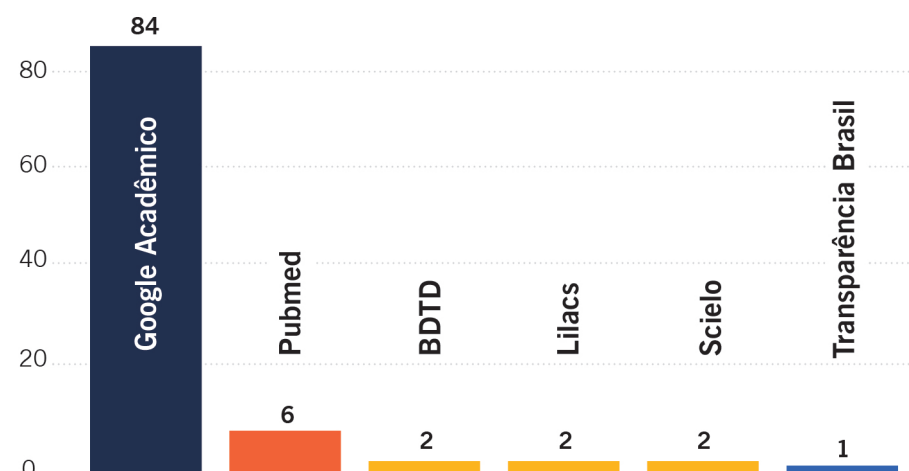
¹⁸ A base com todos os trabalhos analisadas na pesquisa pode ser acessada nesta planilha: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUJjnDmHI3hyodWkpqLQaGpWbSZWnnSvdbLDUL4bXJY/edit?usp=sharing>

¹⁹ O número de resultados do relatório final é inferior ao do relatório parcial porque foram utilizadas mais palavras-chave no Google Acadêmico, como “*compliance*”, por exemplo, para recuperarmos resultados mais próximos do objetivo da pesquisa. Desta forma, o relatório parcial tinha 572 resultados no Google Acadêmico, enquanto o relatório final, mais refinado, retornou 383 resultados.

Distribuição de trabalhos por repositórios científicos

Na primeira parte da seção de resultados apresentaremos, no Gráfico 1, como se deu a distribuição dos trabalhos encontrados por repositórios de pesquisa.

Gráfico 1 – Distribuição dos trabalhos científicos por repositórios



Fonte: Elaboração do autor.

Conforme podemos observar no Gráfico 1, os repositórios com mais resultados aptos foram o Google Acadêmico seguido pela plataforma Pubmed. O gráfico mostra que há somente seis repositórios (de nove), isso se deve à ausência de resultados compatíveis nas plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Artigo 19, Repositório da Controladoria-Geral da União.

Mesmo com diferentes combinações de descritores, as plataformas retornaram sem qualquer resultado que tivesse o mínimo de compatibilidade com a pesquisa. O portal da Transparência Brasil retornou alguns textos sobre a Lei de Combate à Corrupção e a Lei de Acesso à Informação e Ouvidorias, porém, quase todos esses resultados não tinham relação com saúde pública ou com o SUS.

Distribuição de trabalhos por categoria

Ao analisarmos os trabalhos encontrados na busca observamos que os resultados seguem três tendências:

1. Participação social, defesa do usuário, controle social;
2. Avaliação de políticas públicas;
3. *Compliance*, integridade institucional, gestão de riscos e combate à corrupção.

A primeira tendência é composta por trabalhos com foco central na evolução dos mecanismos de participação social e controle social para os usuários do serviço de saúde pública, além da busca por formas de inovação e garantia dos direitos cidadãos para toda a população. Duas legislações que cerceiam essa categoria são a Lei de Acesso à Informação (Brasil, 2011) e a Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público (Brasil, 2017).

A segunda tendência que encontramos foi a de avaliação de políticas públicas. No seu cerne, estão trabalhos voltados a pesquisas elaboradas pelas ouvidorias em saúde para compreender a satisfação de usuários do SUS e a análise dos resultados da implementação de políticas de democratização fomentadas pelas ouvidorias de saúde.

Por fim, a terceira tendência foi a mais escassa e a única das três que mostrou aproximação maior com o objetivo central dessa pesquisa. Nesta terceira tendência o foco são ações de *compliance*, gestão de riscos, combate à corrupção e preservação da integridade e imagem das ouvidorias de saúde. No Gráfico 2, podemos observar os números dessas categorias.

Gráfico 2 – Quantidade de trabalhos por categoria



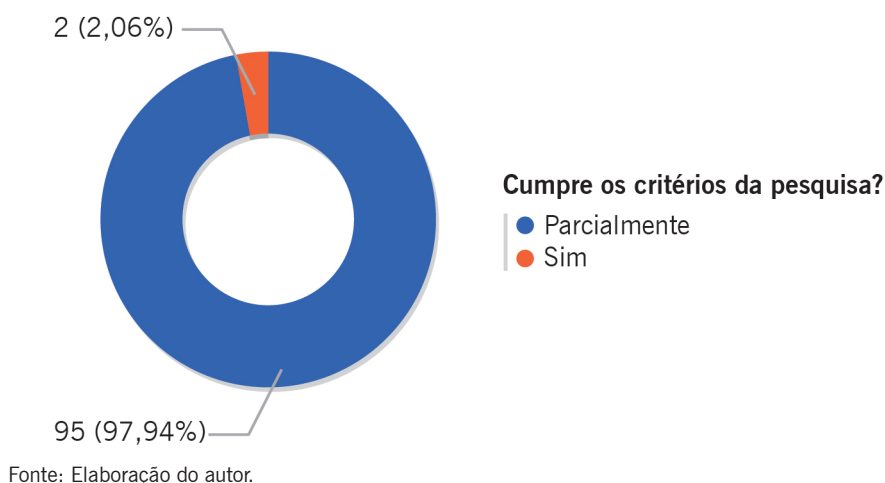
Fonte: Elaboração do autor.

A partir desses números fica evidente como trabalhos com uma abordagem voltada para o *compliance* e o combate à corrupção são bastante escassos, enquanto trabalhos com foco na avaliação de políticas públicas são bem recorrentes.

Perfis da pesquisa

Nesta seção podemos observar a composição do perfil da pesquisa, isto é, quais trabalhos são compatíveis com a temática da pesquisa e quais têm uma compatibilidade parcial, como está presente no gráfico a seguir:

Gráfico 3 – Perfil de pesquisa



No Gráfico 3, pode-se observar que em cerca de 97% dos trabalhos tem um perfil com correspondência parcial ao tema da pesquisa: todos eles tratam sobre os temas ouvidorias da saúde, saúde pública e participação social; porém, nenhum toca nos temas de integridade institucional, combate à corrupção, ações correicionais, gestão de riscos e *compliance* nas ouvidorias em saúde pública. Nesse sentido, somente 2% dos trabalhos têm um perfil minimamente compatível com objeto da pesquisa, ou seja, são centrados em ações de *compliance* e integridade da instituição.

Panorama dos artigos compatíveis

No Quadro 1 a seguir, apresentamos um panorama geral dos únicos dois artigos que mais se aproximam à proposta central da pesquisa.

Quadro 1 – Panorama dos artigos compatíveis com o tema da pesquisa (continua)

AUTOR(ES)	Dantas, Milany Miranda de Sousa (2022).
TÍTULO	Um enfoque sobre controle interno e fortalecimento do canal de denúncia na gestão pública da saúde
OBJETIVO	Analisar as deficiências de controle interno associadas às manifestações externas advindas da sociedade recebidas no canal de denúncia de uma secretaria municipal de saúde.
METODOLOGIA	Pesquisa documental, descritiva e bibliográfica, na qual foram utilizados dados publicados em uma plataforma digital. Assim, empregou-se o site “Painel Resolveu Municipal” de criação recente da Secretaria Executiva da Transparência Pública de uma cidade nordestina, que contém as manifestações oriundas da Ouvidoria Municipal de Saúde.
RESULTADOS	Concluiu-se que o acúmulo de função, o assédio moral, a cobrança indevida e a má conduta, tipificações das denúncias recebidas pelo canal de denúncia no período analisado, estão associados às deficiências de controle interno no que se refere à não observância aos princípios da: segregação de funções, aderência a diretrizes e normas, qualificação adequada e fixação de responsabilidades.

Fonte: Elaboração do autor.

Quadro 1 – Panorama dos artigos compatíveis com o tema da pesquisa (conclusão)

AUTOR(ES)	Silva, Frederico Tadeu da (2021).
TÍTULO	Ouvidoria como instrumento de gestão: estudo de caso na Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
OBJETIVO	Analisar a contribuição da ouvidoria na melhoria da gestão da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), descrevendo as competências de sua ouvidoria, bem como avaliando sua evolução no decorrer dos anos e identificando pontos de convergência com a gestão da própria SES/SC.
METODOLOGIA	Utilizou-se referencial teórico sobre a administração pública, seus tipos e modelos, participação social e controle, conceitos de ouvidor e ouvidoria, e de <i>compliance</i> . A metodologia empregada na pesquisa possui características descritiva e aplicada, com caráter qualitativo, apresentado em forma de estudo de caso. Os métodos de coleta de dados utilizados foram análise documental e entrevistas.
RESULTADOS	A ouvidoria pode ser utilizada como ferramenta para a melhoria da gestão da SES/SC por meio da implementação de relatórios gerenciais e aperfeiçoamento na comunicação entre a ouvidoria e seus <i>stakeholders</i> . Nas políticas de <i>compliance</i> , a ouvidoria tem a capacidade de auxiliar como ferramenta de recebimento de denúncias e reclamações, apoiando as estratégias de enfrentamento.

Fonte: Elaboração do autor.

Nesse panorama pode-se ver que as pesquisas mais voltadas para o *compliance* e a integridade institucional datam do início desta década, o que dá a entender que essa área de pesquisa ainda é bem recente no Brasil. Outro fato que merece destaque é que, apesar de terem como tema central o *compliance*, os dois artigos têm uma abordagem mais voltada para a apresentação do estado da arte de pesquisas sobre as

ouvidorias da saúde e ambos entregam resultados pouco voltados para casos concretos de correição e ajuste interno das ouvidorias no combate a práticas antirrepublicanas.

Nuvem de palavras

Finalizando a parte da apresentação dos resultados deste levantamento, logo a seguir podemos observar uma nuvem de palavras com todas as palavras-chave presentes nos 97 trabalhos acadêmicos avaliados.

Figura 1 – Nuvem de palavras com as palavras-chave dos trabalhos avaliados



Fonte: Elaboração do autor.

Confirmando as afirmações feitas anteriormente, a nuvem de palavras dá destaque a palavras como “saúde”, “participação social”, “avaliação”, “defesa” e “ouvidoria”. Esses termos mais recorrentes nas palavras-chave representam o viés mais voltado para a participação social e garantismo nos trabalhos analisados.

4. Considerações finais

A ouvidoria no SUS exerce um papel muito importante: o de oferecer aos cidadãos e às cidadãs a possibilidade de contribuir ativamente na construção de um sistema de saúde público mais amplo e politicamente engajado com o acesso à saúde para todos. No levantamento feito, pudemos observar que a maioria das pesquisas sobre ouvidoria da saúde tem como foco principal a ampliação da participação social no SUS e a luta pela garantia dos direitos da população. Vale ressaltar que parte dessas pesquisas se referem a trabalhos de conclusão de curso de graduação (TCC) e ainda há pouco material mais específico sobre o tema, em livros, dissertações e teses, sobretudo sob a ótica de *compliance* e combate à corrupção.

Com este levantamento esperamos que os esforços para a produção de pesquisas sobre *compliance* e combate à corrupção exercidos pelas ouvidorias em saúde tornem-se maiores e que por meio desses resultados o Sistema Único de Saúde do Brasil mostre-se ainda mais robusto e amplo para as brasileiras e os brasileiros.

5. Referências

BERTONI, Estevão *et al.* O que é, de onde veio e para onde vai o SUS. *Nexo Jornal*, [s. l.], 28 abr. 2020. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/especial/2020/04/28/O-passado-o-presente-e-o-futuro-do-SUS-para-ler-guardar-e-consultar>. Acesso em: 28 set. 2023.

BRASIL. *Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011*. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n. 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 2 jan. 2024.

BRASIL. *Lei n. 12.846, de 1 de agosto de 2013*. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 2 jan. 2024.

BRASIL. *Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017*. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm. Acesso em: 2 jan. 2024.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. *CGU debate regulamentação nos municípios da Lei do Usuário de Serviços Públicos*. Brasília, DF: CGU, 30 jan. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2023/01/cgu-ganha-nova-estrutura-para-aprimorar-o-combate-a-corrupcao-e-a-execucao-das-politicas-publicas>. Acesso em: 2 out. 2023.

DANTAS, Milany Miranda de Sousa. *Um enfoque sobre controle interno e fortalecimento do canal de denúncia na gestão pública da saúde*. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24170>. Acesso em: 25 set. 2023.

SILVA, Frederico Tadeu da. *Ouvidoria como instrumento de gestão: estudo de caso na Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina*. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/224902>. Acesso em: 21 set. 2023.

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL-BRASIL. *Índice de transparência e governança pública*. São Paulo: Transparência Internacional, 2023. Disponível em: <https://transparenciainternacional.org.br/itgp/>. Acesso em: 29 set. 2023.



Rosa Maria Pinheiro Souza

Sua experiência na formação e na implantação e implementação de ouvidorias do Sistema Único de Saúde (SUS) data de 2013.

Atualmente coordena os projetos:

Fortalecimento da Ouvidoria-Geral do SUS;

Integração e Fortalecimento das Ouvidorias nos Hospitais e Institutos Federais: uma estratégia educacional para fortalecimento da gestão do SUS; e Fortalecimento da Gestão e

Participação Social no SUS: desenvolvimento de ações estratégicas para implantação e implementação de ouvidorias do SUS.

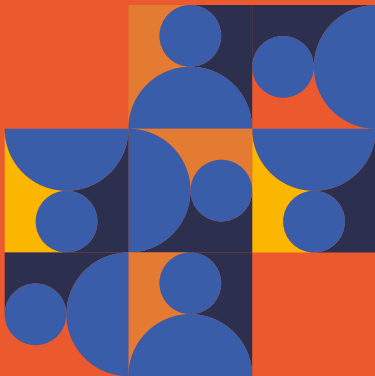
É uma militante apaixonada pelo SUS.



Cristina Ayoub Riche

Advogada, professora e pesquisadora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde implantou a Ouvidoria-Geral, sendo sua gestora de 2008 a 2021. Com larga experiência em ouvidorias, criou e foi a primeira ouvidora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Foi presidente (2019-2023) do Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO). Autora de publicações sobre ouvidorias e direitos humanos, atua como consultora e palestrante. Uma pessoa entusiasmada com a importância de ouvir e escutar para transformar.

Rosa e Cristina se conhecem desde 2013 e, a partir de então, vêm atuando em parceria, desenvolvendo ações para o fortalecimento das ouvidorias do SUS, por meio de eventos institucionais e projetos formativos voltados a gestores e gestoras da área.



Tudo o que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade, ou no meu bairro, acontece comigo. Então, eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida. Um cidadão com um sentimento ético forte e consciência de cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder de participação.
Herbert de Souza (1994).

A ouvidoria do SUS é uma potente ferramenta de democracia participativa. A produção e a disseminação de conhecimentos constituem mecanismos importantes de inovação social e de aperfeiçoamento dos canais de comunicação que aproximam o Estado e a sociedade, no intuito de responder às demandas e necessidades da população brasileira.
Rosa Souza (2024).

ISBN: 978-65-89501-71-8



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO